PART 1 of 5

NURSEHUB EGYPT

Pain Assessment

تقييم الألم

A Comprehensive Clinical Nursing Guide

دليل تمريضي سريري شامل ومتكامل

ICU ▪ Emergency ▪ General Ward ▪ Pediatrics

50+ Sections | Bilingual EN/AR | NCLEX Ready | Evidence-Based | Drug Notes

RN, Ali Ashour, BSN

أخصائي عناية مركزة (ICU) — خبرة 6 سنوات

BLS Certified

nursehub-egypt.vercel.app

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

Table of Contents

فهرس المحتويات — Pain Assessment / تقييم الألم

⚡ PART 1 — Foundation & Science Pages 3–12

1 Learning Objectives الأهداف التعليمية
2 Quick Facts الحقائق السريعة
3 Evidence-Based Practice الدليل العلمي
4 Introduction المقدمة
5 Definition (IASP 2020) التعريف
6 Types & Sources of Pain أنواع الألم
7 Gate Control Theory نظرية بوابة الألم
8 Pain Manifestations مظاهر الألم
9 Importance الأهمية

PART 2 — Assessment Core Pages 13–26

10 Anatomy & Physiology التشريح والفسيولوجيا
11 Medical Terminology المصطلحات الطبية
12 PQRSTU & OLDCARTS أنظمة التقييم
13 Subjective Data البيانات الذاتية
14 Objective Assessment التقييم الموضوعي
15 Pain Scales (All Tools) جميع المقاييس
16 Adult Pain Tools أدوات البالغين
17 Indications دواعي التقييم
18 Contraindications الموانع
19 Preparation & Equipment التحضير والأدوات
20 Nursing Procedure الإجراء التمريضي

PART 3 — Advanced & Special Populations Pages 27–40

21 Scientific Rationales التسويغ العلمي
22 Nursing Tips نصائح تمريضية
23 Documentation التوثيق
24 Sample Documentation نموذج التوثيق
25 Infection Control مكافحة العدوى
26 Safety Precautions احتياطات السلامة
27 Common Mistakes الأخطاء الشائعة
28 Red Flags العلامات الحمراء
29 Decision Trees أشجار القرار
30 Abnormal Findings النتائج غير الطبيعية
31 Drug Notes ملاحظات الأدوية
32 Pediatric Assessment تقييم الأطفال
33 Children's Pain Tools أدوات الأطفال
34 QUESTT Approach نهج QUESTT
35 Age-Specific Challenges تحديات الأعمار
36 Elderly & Dementia كبار السن والخرف
37 Pregnancy Considerations الحوامل
38 ICU Considerations العناية المركزة

PART 4 — Exam Preparation Pages 41–54

39 Early Warning Scores مقاييس التحذير
40 Emergency Tips الطوارئ
41 Clinical Pearls & Wisdom لآلئ سريرية
42 Clinical Case Studies (3) حالات سريرية
43 Quick Revision مراجعة سريعة
44 Cheat Sheet الورقة المرجعية
45 OSCE Checklist قائمة OSCE
46 OSCE Examiner Tips نصائح الممتحن
47 Memory Tricks وسائل الحفظ
48 MCQs أسئلة اختيار
49 True / False صح أم خطأ
50 Fill in the Blanks أكمل الفراغ

PART 5 — AI Review & References Pages 55–66

51 Interactive Quiz اختبار تفاعلي
52 AI Flashcards بطاقات المراجعة
53 AI Revision Notes ملخص الامتحانات
54 Licensing Exam Tips نصائح الترخيص
55 FAQ الأسئلة الشائعة
56 Key Takeaways أهم النقاط
57 Tools Advantages/Disadvantages مقارنة الأدوات
58 Related Articles مقالات ذات صلة
59 References (APA 7) المراجع

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

01 — Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this guide, the learner will be able to:

🧠 Cognitive Objectives (Knowledge)

- **Define** pain according to the IASP (2020) revised definition
- **Identify** the four stages of the pain pathway: transduction, transmission, perception, and modulation
- **Classify** pain types: acute vs. chronic, nociceptive vs. neuropathic, somatic vs. visceral vs. referred vs. phantom
- **Explain** the Gate Control Theory of Pain and its clinical significance
- **List** validated assessment tools: NRS, VAS, VDS, Wong-Baker FACES, CPOT, BPS, FLACC, TVP, PAINAD, Pain Thermometer, APCA POS
- **Describe** PQRSTU / OPQRST / OLDCARTS mnemonics for pain history
- **Differentiate** between subjective and objective pain data
- **Describe** pain manifestations: pallor, diaphoresis, tachycardia, hypertension, nausea, anxiety, clenched fists, restlessness
- **Recall** the QUESTT approach for pediatric pain assessment
- **Explain** the WHO Analgesic Ladder and multimodal analgesia

✦ ✦ ✦

🧠 الأهداف المعرفية (المعلومات)

- **تعريف** الألم وفقاً لتعريف IASP المحدّث (2020)
- **تحديد** المراحل الأربعة لمسار الألم: التحويل، النقل، الإدراك، والتعديل
- **تصنيف** أنواع الألم: حاد/مزمن، وجداني/عصبي، جسدي/حشوي/مُحال/وهمي
- **شرح** نظرية بوابة الألم وأهميتها السريرية
- **سرد** أدوات التقييم المعتمدة: NRS، VAS، VDS، Wong-Baker، CPOT، BPS، FLACC، TVP، PAINAD، الحرارة، APCA POS
- **وصف** أنظمة PQRSTU / OPQRST / OLDCARTS لتاريخ الألم
- **التفريق** بين البيانات الذاتية والموضوعية
- **وصف** مظاهر الألم: شحوب، تعرق، تسرع قلب، ارتفاع ضغط، غثيان، قلق، قبض اليدين، تململ
- **تذكر** نهج QUESTT لتقييم ألم الأطفال
- **شرح** سلم WHO للمسكنات ونهج المسكنات متعددة الوسائط

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Psychomotor & Affective Objectives / الأهداف المهارية والوجدانية

Psychomotor Objectives (Skills)

- Perform systematic pain assessment using PQRSTU format
- Select the most appropriate pain scale per patient type and age
- Document pain accurately using standardized formats
- Reassess pain 15 min post-IV and 30 min post-oral analgesic
- Recognize non-verbal pain cues in ICU, pediatric, and dementia patients
- Apply the FLACC scale for children under 3 years
- Use the CPOT/BPS for intubated ICU patients
- Perform comprehensive assessment including behavioral and physiological indicators
- Use body diagrams to locate pain areas
- Provide non-pharmacological interventions based on Gate Control Theory

الأهداف المهارية

- إجراء تقييم منهجي باستخدام نظام PQRSTU
- اختيار المقياس المناسب حسب نوع وعمر المريض
- توثيق الألم بدقة باستخدام نماذج موحدة
- إعادة التقييم 15 دقيقة بعد IV و30 دقيقة بعد فموي
- التعرف على مؤشرات الألم غير اللفظية في ICU والأطفال والخرف
- تطبيق مقياس FLACC للأطفال أقل من 3 سنوات
- استخدام CPOT/BPS للمرضى على التنفس الصناعي
- إجراء تقييم شامل يتضمن المؤشرات السلوكية والفسيولوجية
- استخدام مخططات الجسم لتحديد مناطق الألم
- تقديم تدخلات غير دوائية بناء على نظرية بوابة الألم

Affective Objectives / الأهداف الوجدانية

EN:

- Appreciate pain as "the 5th vital sign"
- Accept the patient's self-report as the gold standard
- Advocate for adequate pain management
- Show empathy and cultural sensitivity
- Avoid undertreating or overtreating pain
- Understand pain assessment is NOT an academic exercise — every question provides essential information

AR:

- تقدير الألم كـ "العلامة الحيوية الخامسة"
- قبول تقرير المريض كمعيار ذهبي
- المناصرة لإدارة مناسبة للألم
- إظهار التعاطف والحساسية الثقافية
- تجنب الإفراط أو التقصير في العلاج
- فهم أن التقييم ليس تمريناً أكاديمياً — كل سؤال يوفر معلومات أساسية

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

02 — Quick Facts الحقائق السريعة

Essential Pain Assessment Numbers / أرقام يجب حفظها

0–10 NRS Range مقياس NRS	**≥ 4** Moderate Pain ألم متوسط	**1–3** Mild Pain ألم خفيف	**7–10** Severe Pain ألم شديد
30 min Post-Oral Reassess بعد فموي	**15 min** Post-IV Reassess بعد وريدي	**CPOT** Best ICU Tool أفضل مقياس ICU	**FLACC** Pediatric <3 yr أطفال أقل من 3
PAINAD Dementia Scale مقياس الخرف	**APCA** African POS 0–5 أفريقي 0-5	**VAS** Visual 0-100mm بصري	**Wong** 6 Faces (kids) أطفال 3-8

Pain Severity Visual Scale / مقياس شدة الألم المرئي

😊 No Pain — 😕 Moderate — 😣 Severe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0–3: No therapy change ▪ **4–7:** Change analgesic ▪ **8–10:** Pain Emergency

The Golden Rule of Pain Assessment / القاعدة الذهبية

EN: Pain is subjective. The patient's self-report is the **gold standard**. *"Pain is whatever the experiencing person says it is, existing whenever the person says it does."* (McCaffery, 1968)

AR: الألم ذاتي. تقرير المريض هو **المعيار الذهبي**. "الألم هو ما يقوله الشخص الذي يعانيه، موجود حيثما يقول"

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

P OPQRST Complete Reference / المرجع الكامل

Letter	Full Term	Question to Ask	بالعربي
O	Onset	When did the pain begin? How did it start?	متى بدأ الألم؟ كيف بدأ؟
P	Provocation / Palliation	What makes it worse? What makes it better?	ما الذي يزيده؟ يقلله؟
Q	Quality	Sharp, dull, burning, aching, crushing?	حاد، خفيف، حارق، ساحق؟
R	Region / Radiation	Where is it? Does it spread anywhere?	أين يوجد؟ هل ينتشر؟
S	Severity	Rate pain on scale 0–10	قيّم من 0–10
T	Time / Temporal	Continuous or intermittent? How long?	مستمر أم متقطع؟ لأي مدة؟

All 11 Pain Assessment Tools / جميع أدوات تقييم الألم

Tool / الأداة	Population	Range	Special Use
NRS Numerical Rating	Adults, conscious	0–10	Most common ✓ can be verbal
VAS Visual Analogue	Adults, literate	0–100mm	Research & chronic pain
VDS Verbal Descriptor	Adults, all literacy	6 descriptors	No pain → Worst possible
Wong-Baker FACES	Children 3–8 yr	0–10 (6 faces)	No literacy needed 😊
FLACC	<3 yr / non-verbal	0–10 (5 criteria)	Post-op pediatric
TVP Touch Visual Pain	Children non-verbal	0–10 (touch)	Touch + observation
CPOT	ICU / intubated	0–8	Gold standard ICU ⭐
BPS Behavioral Pain Scale	ICU / sedated	3–12	Mechanically ventilated
PAINAD	Dementia / elderly	0–10	Alzheimer's patients
Pain Thermometer	7+ yr / cognitive deficit	Descriptors	Adapted VDS with visual
APCA POS	Palliative care	0–5	WHO-promoted, hand scale

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Foundation Guidelines & Best Practices / الإرشادات الأساسية

Key Foundational Guidelines:

- The **IASP (2020)** redefined pain as: *"An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage."* (Raja et al., 2020)
- **Joint Commission (2017)** standards require pain assessment at every clinical encounter and documentation of reassessment within 30–60 minutes of any intervention.
- **WHO Analgesic Ladder** (1986, updated 2019): evidence-based framework for stepwise pain management: non-opioid → weak opioid → strong opioid. (WHO, 2019)
- **PADIS Guidelines (2018)** — Society of Critical Care Medicine: recommend CPOT as the preferred tool for ICU pain assessment in non-verbal patients. (Devlin et al., 2018)
- The **effective clinical management of pain depends on its accurate assessment**, entailing a comprehensive evaluation of pain, symptoms, functional status, and clinical history. (Powell et al.)
- **Pain assessment is an ongoing process** — not an isolated event. Treatment interventions must be evaluated via subsequent assessments to determine effectiveness. (Powell et al.)

✦ ✦ ✦

الإرشادات الأساسية الرئيسية:

- **IASP (2020)** أعادت تعريف الألم: "تجربة حسية وعاطفية غير سارة مرتبطة بتلف فعلي أو محتمل للأنسجة أو تشبهه"
- **Joint Commission (2017)** تُلزم بتقييم الألم في كل زيارة وتوثيق إعادة التقييم خلال 30–60 دقيقة من أي تدخل.
- **سلم WHO للمسكنات** (محدّث 2019): إطار تدريجي: غير أفيوني ← أفيوني خفيف ← أفيوني قوي.
- **إرشادات PADIS (2018)**: تُوصي بـ CPOT لتقييم ألم ICU للمرضى غير اللفظيين.
- **الإدارة الفعالة للألم تعتمد على تقييمه الدقيق**، ويستلزم تقييماً شاملاً للألم والأعراض والحالة الوظيفية والتاريخ السريري.
- **تقييم الألم عملية مستمرة** — ليست حدثاً منفرداً. يجب تقييم فعالية التدخل عبر تقييمات لاحقة.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Landmark Studies in Pain Assessment / دراسات محورية

Study / الدراسة	Finding / النتيجة	Level of Evidence
Gélinas et al. (2006)	CPOT: sensitivity 86%, specificity 78% in ICU patients	Level II RCT
Herr et al. (2011)	30–80% of elderly in LTC have undertreated pain; PAINAD most reliable	Level II Sys. Review
RNAO (2013)	Routine pain assessment improves patient outcomes by 40%	Level I CPG
WHO (2019)	Multimodal analgesia reduces opioid consumption by 30–50%	Level I WHO
Merkel et al. (1997)	FLACC validated for non-verbal children (0–10 scale)	Level II
Bates (1991)	PQRST critical components established for pain assessment	Level III
Baker & Wong (1987)	QUESTT approach developed for pediatric pain assessment	Level III
Powell et al. (IASP)	Comprehensive guide for pain management in low-resource settings	Level I IASP
Melzack & Wall (1965)	Gate Control Theory — landmark theory of pain modulation	Level I Theory
Devlin et al. (2018)	PADIS Guidelines — SCCM ICU pain recommendations	Level I CPG
McCaffery (1968)	Established patient self-report as gold standard	Level III

Best Practice Summary / ملخص أفضل الممارسات

EN:

- Use **multimodal analgesia** (non-pharm + pharm)
- Patient-Controlled Analgesia (PCA) reduces anxiety
- Assess pain q4h minimum in hospital
- Use validated scales — never estimate visually
- Reassess after intervention (15 min IV / 30 min oral)
- Always accept patient's self-report

AR:

- استخدم **مسكنات متعددة الوسائط**
- PCA يُقلل القلق ويُحسن الرضا
- تقييم كل 4 ساعات كحد أدنى
- استخدم مقاييس معتمدة — لا تُقدر بالنظر
- إعادة التقييم (15 دقيقة IV / 30 دقيقة فموي)
- اقبل دائماً تقرير المريض الذاتي

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

1-6 Complete Framework by Powell et al. (IASP)

What can be done to ensure an effective pain assessment process?

1. Accept the patient's self-reported pain as accurate. Pain is an inherently subjective experience influenced by multiple factors (gender differences, socially acceptable pain thresholds, culturally acceptable levels of "complaining," hopelessness, diminished morale, coping abilities, and the meaning attached to the pain). Accept the patient as an **expert on his or her own body**. While some patients may exaggerate their pain, this will generally be the exception. Evidence suggests that health care providers' observational pain report cannot be assumed to be an accurate indicator of the patient's pain.

2. Allow patients to describe their pain in their own words. The fact that patients may report socially acceptable answers demands a sensitive exploration. For patients uncomfortable expressing themselves, provide a sample of relevant words written on cards from which the patient can select the most appropriate descriptors. The primary intention is to **listen to the patient** rather than make false assumptions.

3. Listen actively to what the patient says. Focus attention on the patient, observe behavioral and body language, and paraphrase words when necessary to ensure clear understanding. In emotionally charged encounters, actively listen for **nonverbal descriptors**.

4. Use body diagrams to locate the pain. Show the patient a picture of the human body (front and back), request they indicate primary and multiple areas of pain, and demonstrate the direction of any radiated pain.

5. Use pain scales to measure severity. Pain scales (of varying complexity) can be used to determine the severity of the expressed pain.

6. Diagnose the cause and treat. While important to manage pain as soon as possible, **diagnose the cause** of the pain and treat if possible, ensuring longer-term resolution.

Source: Powell, R.A., Downing, J., Ddungu, H., & Mwangi-Powell, F.N. Guide to Pain Management in Low-Resource Settings, Chapter 10 (IASP).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

ما الذي يمكن فعله لضمان عملية تقييم ألم فعالة؟

1. **اقبل تقرير المريض الذاتي عن ألمه كدقيق.** الألم تجربة ذاتية بطبيعتها تتأثر بعوامل متعددة (الجنس، العتبات المقبولة اجتماعياً، المعتقدات الثقافية، اليأس، الروح المعنوية، قدرات التكيف، ومعنى الألم للشخص). اقبل المريض **كخبير في جسده**. بينما قد يبالغ بعض المرضى في ألمهم، فهذا استثناء نادر. الأدلة تشير أن تقرير الممرض الملاحظ لا يمكن افتراضه مؤشراً دقيقاً لألم المريض.
2. **اسمح للمرضى بوصف ألمهم بكلماتهم.** حقيقة أن المرضى قد يعطون إجابات مقبولة اجتماعياً تتطلب استكشافاً حساساً. للمرضى الذين يشعرون بعدم الارتياح، قدم بطاقات بكلمات وصفية يختارون منها الأنسب. النية الأساسية هي **الاستماع للمريض** وليس الافتراضات الخاطئة.
3. **استمع بنشاط لما يقوله المريض.** ركز انتباهك على المريض، لاحظ لغة الجسد، وأعد صياغة الكلمات للتأكد من الفهم. في المواقف العاطفية، استمع للمؤشرات **غير اللفظية**.
4. **استخدم مخططات الجسم لتحديد الألم.** اعرض صورة الجسم البشري (الأمام والخلف)، اطلب من المريض تحديد مناطق الألم الأساسية والمتعددة وإظهار اتجاه الألم المنتشر.
5. **استخدم مقاييس الألم لقياس الشدة.** مقاييس الألم (بدرجات تعقيد متفاوتة) تُستخدم لتحديد شدة الألم المُعبَّر عنه.
6. **شخّص السبب وعالج.** بينما من المهم إدارة الألم بسرعة، شخّص أيضاً **سبب الألم** وعالجه لضمان حل طويل الأمد.

⏱ How Long Should Assessment Take? / كم يستغرق التقييم؟

AR: يختلف الوقت حسب المرضى ومتطلبات العيادة. المرضى في ألم شديد قد لا يستطيعون تقديم معلومات ذات معنى. قد يحتاج التقييم أن يكون مختصراً. **جودة التقييم، وليس كمية الوقت، هي ما يُنتج إدارة فعالة للألم.**

EN: Time varies according to individual patients and clinic demands. Patients in severe pain may be unable to provide meaningful information. Assessment may need to be brief (intensity, quality, location) so pain management can be provided quickly. **It is the quality of the pain assessment, not the quantity of time, that results in effective pain management.**

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Why Pain Assessment Matters / لماذا يهم تقييم الألم؟

Pain is an unpleasant sensation and emotional experience that links to tissue damage. (Devisri, R., Karpaga Vinayaga College of Nursing)

Pain is one of the most common reasons patients seek medical care, yet it remains one of the most **undertreated conditions** in clinical settings worldwide. As nurses, we serve as the primary assessors and advocates for our patients' pain experience.

Pain affects every aspect of a patient's well-being: it **disrupts sleep, delays wound healing, causes respiratory complications** (splinting), increases stress hormones, leads to anxiety and depression, and significantly impairs quality of life.

The **Joint Commission** recognized pain as the "5th Vital Sign" to emphasize that it must be assessed as routinely and systematically as temperature, pulse, respiration, and blood pressure.

Where pain levels permit, the assessment process is essentially **a dialogue between the patient and the health care provider** that addresses the nature, location, and extent of the pain, its impact on daily life, and treatment options. (Powell et al.)

✦ ✦ ✦

الألم هو إحساس غير سار وتجربة عاطفية مرتبطة بتلف الأنسجة.

يُعدّ الألم من أكثر الأسباب شيوعاً التي تدفع المرضى للبحث عن الرعاية الطبية، ومع ذلك يظل من أكثر الحالات **سوء المعالجة** في البيئات السريرية حول العالم.

يؤثر الألم على كل جانب من صحة المريض: **يُعطل النوم، يُؤخر التئام الجروح، يُسبب مضاعفات تنفسية**، يرفع هرمونات التوتر، يُفضي للقلق والاكتئاب، ويُضعف جودة الحياة.

اعترفت **الرابطة المشتركة** بالألم كـ "العلامة الحيوية الخامسة" للتأكيد على ضرورة تقييمه بانتظام مثل درجة الحرارة والنبض والتنفس وضغط الدم.

عندما يسمح مستوى الألم، فإن عملية التقييم هي في جوهرها **حوار بين المريض ومقدم الرعاية** يتناول طبيعة الألم وموقعه وتأثيره على الحياة اليومية.

The Cost of Unmanaged Pain / تكلفة الألم غير المُعالج

Clinical Consequences:

- Delayed recovery & wound healing
- Pneumonia risk (splinting)
- DVT & PE
- Prolonged ICU stay

العواقب السريرية:

- تأخر التعافي والتئام الجروح
- خطر الالتهاب الرئوي
- DVT وانصمام رئوي
- إطالة إقامة ICU

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Official IASP Definition & Related Terms / التعريف الرسمي

IASP Official Definition (2020)

"An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage."

— International Association for the Study of Pain (IASP), 2020 — Raja, S.N. et al., Pain, 161(9), 1976–1982.

التعريف الرسمي (IASP 2020)

"تجربة حسية وعاطفية غير سارة مرتبطة بتلف فعلي أو محتمل للأنسجة، أو تشبه ما يرتبط بهذا التلف."

— الرابطة الدولية لدراسة الألم (IASP)، 2020

Don't Let Pain Define You / لا تدع الألم يعرّفك

EN: Pain is subjective — the patient's self-report is **always the gold standard** when they can communicate. Never doubt the patient's pain report. *"Pain is whatever the experiencing person says it is, existing whenever the person says it does."* (McCaffery, 1968)

AR: الألم ذاتي — تقرير المريض عن ألمه هو **المعيار الذهبي دائماً**. لا تشك أبداً فيما يقوله المريض. "الألم هو ما يقوله الشخص الذي يعانيه، موجود حيثما يقول"

Related Pain Terminology / مصطلحات مرتبطة

Term / المصطلح	Definition	بالعربي
Nociception	Neural process of encoding noxious stimuli	استقبال المنبهات الضارة
Allodynia	Pain from non-painful stimulus	ألم من منبه غير مؤلم
Hyperalgesia	Increased response to painful stimulus	استجابة مفرطة للألم
Analgesia	Absence of pain in response to stimulus	غياب الألم
Paresthesia	Abnormal sensation (tingling)	إحساس غير طبيعي (تنميل)

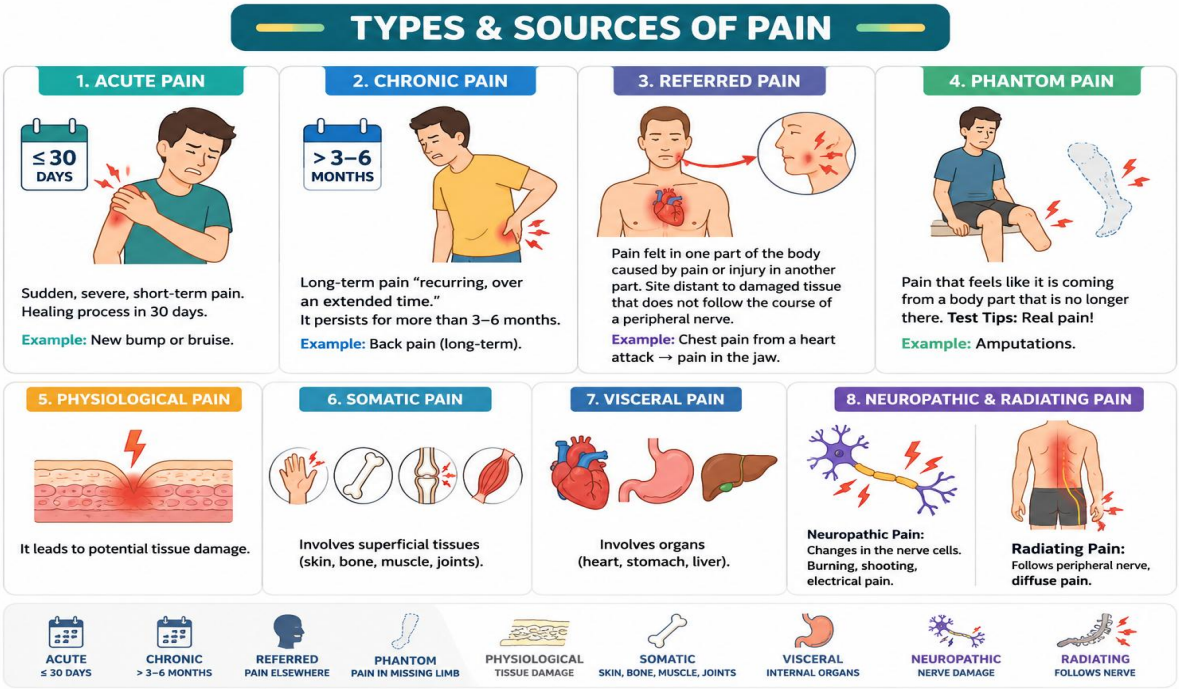
RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Complete Pain Classification / تصنيف الألم الشامل

Types & Sources of Pain (Complete List):

- **Acute Pain:** Sudden, severe, short-term pain. Healing process in 30 days. *Example:* New bump or bruise.
- **Chronic Pain:** Long-term pain "recurring, over an extended time." It persists for more than 3–6 months. *Example:* Back pain (long-term).
- **Referred Pain:** The feeling of pain in one part of the body is caused by pain or injury in another part. Site distant to damaged tissue that does not follow the course of a peripheral nerve. *Example:* Chest pain from a heart attack could trigger pain in the jaw.
- **Phantom Pain:** Pain that feels like it is coming from a body part that is no longer there. **Test Tips:** Real pain! *Example:* Amputations.
- **Physiological Pain:** It leads to potential tissue damage.
- **Somatic Pain:** Involves superficial tissues (skin, bone, muscle, joints).
- **Visceral Pain:** Involves organs (heart, stomach, liver).
- **Neuropathic Pain:** Changes in the nerve cells. Described as burning, shooting, electrical.
- **Radiating Pain:** Follows peripheral nerve, diffuse pain.

Sources: SimpleNursing — Pathophysiology Course, p.74; Devisri, R. — PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

أنواع ومصادر الألم (القائمة الكاملة):

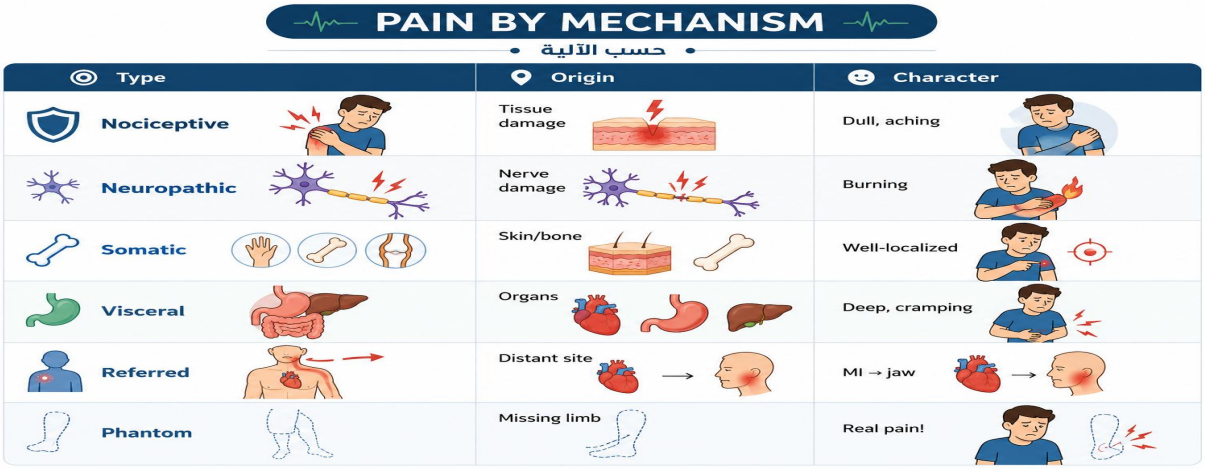
- **الألم الحاد:** مفاجئ، شديد، قصير المدة. الشفاء في 30 يوماً. *مثال:* كدمة جديدة.
- **الألم المزمن:** طويل الأمد "متكرر، لفترة ممتدة" يستمر لأكثر من 3–6 أشهر. *مثال:* آلام الظهر المزمنة.
- **الألم المُحال:** الشعور بالألم في جزء من الجسم سببه إصابة في جزء آخر. لا يتبع مسار العصب المحيطي. *مثال:* ألم الصدر من النوبة القلبية يمكن أن يُسبب ألماً في الفك.
- **الألم الوهمي:** ألم يبدو قادماً من جزء من الجسم لم يعد موجوداً. **نصيحة اختبار:** ألم حقيقي! *مثال:* بتر الأطراف.
- **الألم الفسيولوجي:** يؤدي إلى تلف محتمل في الأنسجة.
- **الألم الجسدي:** يشمل الأنسجة السطحية (الجلد، العظم، العضلات، المفاصل).
- **الألم الحشوي:** يشمل الأعضاء (القلب، المعدة، الكبد).
- **الألم العصبي:** تغيرات في الخلايا العصبية. يوصف بأنه حارق، خاطف، كهربائي.
- **الألم المنتشر:** يتبع العصب المحيطي، ألم منتشر.

By Duration / حسب المدة

Type	Duration	Example
Acute	<30 days	Post-op, trauma
Chronic	>3–6 months	Arthritis
Recurrent	Episodic	Migraine

By Mechanism / حسب الآلية

Type	Origin	Character
Nociceptive	Tissue damage	Dull, aching
Neuropathic	Nerve damage	Burning
Somatic	Skin/bone	Well-localized
Visceral	Organs	Deep, cramping
Referred	Distant site	MI → jaw
Phantom	Missing limb	Real pain!



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Quality Descriptors Help Identify Etiology / الواصفات تساعد في تحديد السبب

★ Pain Quality Diagnostic Pearls (Powell et al.)

EN: Pain quality helps differentiate etiology:

- "**Burning, shooting, electrical**" → **neuropathic pain**
- "**Dull, aching**" → **nociceptive pain**
- "**Terrible, unbearable**" → **affective valuation**
- Pain worse in **early morning hours** → inflammation
- Constant high pain → **chronic pain disease**
- Pain decrease with **movement** → possible osteoarthritis
- Only **rest relieves pain** → chronic pain, cognitive restructuring needed

AR: جودة الألم تساعد في تمييز السبب:

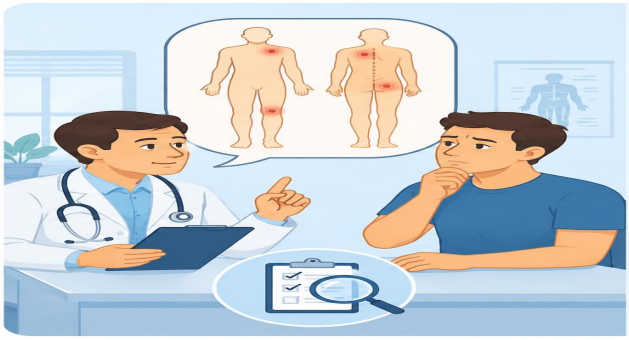
- "**حارق، خاطف، كهربائي**" ← **ألم عصبي**
- "**خفيف، مؤلم**" ← **ألم وجداني**
- "**رهيب، لا يُحتمل**" ← **تقييم عاطفي**
- الألم أسوأ في **الصباح الباكر** ← التهاب
- ألم عالٍ مستمر ← **مرض ألم مزمن**
- انخفاض الألم مع **الحركة** ← هشاشة عظام
- الراحة فقط تخفف ← ألم مزمن يحتاج إعادة هيكلة إدراكية

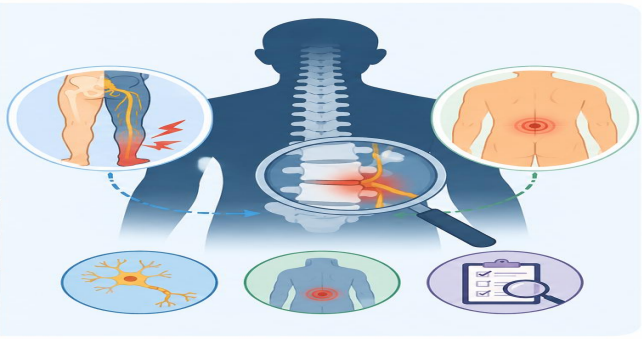
Source: Powell, R.A., Downing, J., Ddungu, H., & Mwangi-Powell, F.N. Guide to Pain Management in Low-Resource Settings, Chapter 10 (IASP).

Localization — The Most Important Question / التوطين — السؤال الأهم

EN: Localization is probably the most important question in pain assessment. Localization of the pain may differentiate between a **radicular** and **nonradicular** etiology of pain. The items mentioned are only rough indicators of certain etiologies. Further questioning and examination must be undertaken to confirm suspicions.

AR: التوطين ربما يكون السؤال الأهم في تقييم الألم. توطين الألم قد يميّز بين السبب **الجذري (Radicular)** و**غير الجذري (Non-radicular)**. العناصر المذكورة مجرد مؤشرات تقريبية. يجب إجراء استجواب وفحص إضافي لتأكيد الشكوك.





RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Gate Control Theory (Melzack & Wall, 1965)

Gate Control Theory of Pain:

1. Gates are built into normal pain pathways
2. Gates **open** & pain impulse is transmitted to the brain
3. Gates **close** & pain impulse is reduced

This theory, proposed by **Melzack & Wall (1965)**, explains how non-painful stimuli can override and reduce the perception of painful stimuli. When the "gate" is open, pain signals pass through to the CNS. When the gate is closed (through touch, pressure, or distraction), pain signals are inhibited.

Clinical Application: This theory supports the use of non-pharmacological interventions like **massage, heat/cold therapy, TENS units, and distraction techniques** to "close the gate" and reduce pain perception.

Sources: SimpleNursing, p.74; Melzack, R. & Wall, P.D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. Science, 150(3699), 971–979.

✦ ✦ ✦

نظرية بوابة التحكم في الألم:

1. بوابات مبنية في مسارات الألم الطبيعية
2. البوابات **تفتح** ونبضة الألم تنتقل إلى الدماغ
3. البوابات **تغلق** ونبضة الألم تقل

هذه النظرية التي اقترحها **ميلزاك ووول (1965)**، تُفسر كيف يمكن للمنبهات غير المؤلمة أن تتغلب على إدراك المنبهات المؤلمة وتقللها. عندما تكون "البوابة" مفتوحة تمر إشارات الألم للجهاز العصبي المركزي. عندما تُغلق (عبر اللمس أو الضغط أو الإلهاء) تُمنع إشارات الألم.

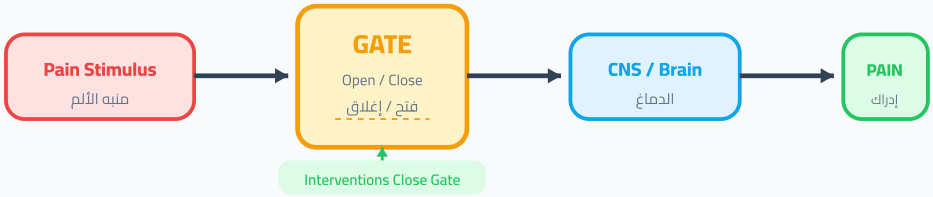
التطبيق السريري: تدعم هذه النظرية استخدام التدخلات غير الدوائية كـ **التدليك والعلاج بالحرارة/البرودة وأجهزة TENS وتقنيات الإلهاء** لـ "إغلاق البوابة" وتقليل إدراك الألم.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Visual Flow Diagram / رسم توضيحي للمسار

Gate Control Pathway Visualization / تصور مسار البوابة

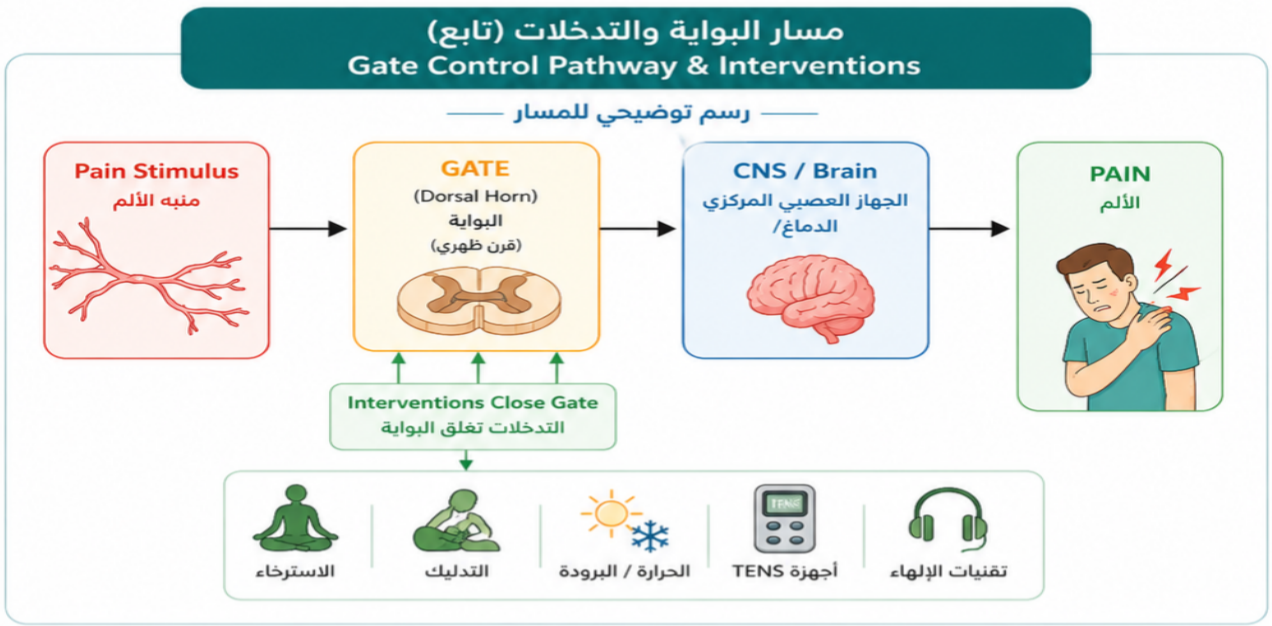


Gate-Closing Interventions

- **Massage** — activates large fibers
- **Heat / Cold therapy**
- **TENS** (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
- **Distraction** (music, TV, conversation)
- **Guided imagery / meditation**
- **Deep breathing exercises**
- **Positioning & repositioning**

التدخلات المُغلقة للبوابة

- **التدليك** — يُنشط الألياف الكبيرة
- **العلاج بالحرارة / البرودة**
- **TENS** (التحفيز الكهربائي عبر الجلد)
- **الإلهاء** (موسيقى، تلفزيون، حوار)
- **التخيّل الموجّه / التأمل**
- **تمارين التنفس العميق**
- **وضعيات الجسم وتغييرها**



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Clinical Signs & Symptoms of Pain / علامات وأعراض الألم

Signs & Symptoms of Pain:

- **Pallor** (pale)
- **Diaphoresis** (sweating)
- **Tachycardia** (HR 100+)
- **High Blood Pressure** (over 140 systolic)
- **Nausea & vomiting** (acute)
- **Fainting / dizziness** (acute)
- **Anxiety / fear** (chronic pain or trauma)
- **Clenched fists**
- **Restlessness**

Source: SimpleNursing — Pathophysiology Course, p.74

العلامات والأعراض:

- **شحوب** (Pallor)
- **تعرق** (Diaphoresis)
- **تسرع نبض القلب** (معدل نبض 100+)
- **ارتفاع ضغط الدم** (أكثر من 140 انقباضي)
- **غثيان وقيء** (في الألم الحاد)
- **إغماء / دوخة** (في الألم الحاد)
- **قلق / خوف** (ألم مزمن أو صدمة)
- **قبض اليدين**
- **تململ**

Physiological Responses to Pain / الاستجابات الفسيولوجية للألم

EN: Physiological responses vary with the origin and duration of pain. Early in onset of acute pain, the **sympathetic nervous system** is stimulated. This results in:

- Increased blood pressure
- Increased pulse rate
- Increased respiration
- Pallor
- Diaphoresis
- Pupil dilation

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management.

AR: تختلف الاستجابات الفسيولوجية حسب منشأ ومدة الألم. في بداية الألم الحاد يُثار **الجهاز العصبي الودي**، مما يؤدي إلى:

- ارتفاع ضغط الدم
- زيادة معدل النبض
- زيادة التنفس
- شحوب
- تعرق
- اتساع الحدقة



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Behavioral Effects — Objective Assessment / التأثيرات السلوكية

Objective Assessment — Behavioral Effects:

- Assess **verbalization, vocal response, facial and body movements & social interaction**
- **Facial expression** is often the 1st indication of pain & may be the only manifestation
- Vocalizations like **moaning, groaning, crying, grunting, screaming** are associated with pain

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.

✦ ✦ ✦

التقييم الموضوعي — التأثيرات السلوكية:

- تقييم **اللفظ، الاستجابة الصوتية، حركات الوجه والجسم والتفاعل الاجتماعي**
- **تعبير الوجه** غالباً أول مؤشر للألم وقد يكون المظهر الوحيد
- الأصوات مثل **الأنين، التأوه، البكاء، الشخير، الصراخ** ترتبط بالألم

4 The 4 Pillars of Nursing Assessment / أعمدة التقييم التمريضي

Risk	Response	Site	S&S
خطر الألم	الاستجابة	الموقع	علامات وأعراض

EN: Nursing Assessment includes: (1) Assess risk for pain (invasive procedures, anxious patients), (2) Response to previous pharmacological interventions, (3) Examine site of pain/discomfort, (4) Assess physical, behavioral and emotional signs (moaning, decreased activity, abnormal guilt, irritability).

AR: التقييم التمريضي يشمل: (1) تقييم خطر الألم، (2) الاستجابة للتدخلات الدوائية السابقة، (3) فحص موقع الألم، (4) تقييم العلامات الجسدية والسلوكية والعاطفية.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

09 — Importance of Pain Assessment أهمية تقييم الألم

Why Accurate Pain Assessment is Critical / لماذا التقييم الدقيق حاسم؟

The effective clinical management of pain ultimately depends on its accurate assessment. (Powell et al.)

Accurate pain assessment is critical because:

- **Directs treatment decisions** — the intensity guides intervention: 0–3 no change, 4–7 change analgesic, 8–10 emergency
- **Prevents complications** of unmanaged pain: chronic pain development, depression, sleep disturbances
- **Identifies etiology** — quality descriptors help differentiate neuropathic vs. nociceptive
- **Evaluates treatment effectiveness** — reassessment determines if intervention worked
- **Improves patient satisfaction** and quality of life
- **Prevents undertreatment** — especially in elderly, cognitively impaired, non-verbal
- **Prevents overtreatment** — avoids opioid dependency and adverse effects
- **Legal & ethical obligation** — pain management is fundamental patient right (Joint Commission)

✦ ✦ ✦

الإدارة السريرية الفعالة للألم تعتمد في النهاية على تقييمه الدقيق.

التقييم الدقيق للألم حاسم لأنه:

- **يوجّه قرارات العلاج** — الشدة تحدد التدخل: 0–3 لا تغيير، 4–7 تغيير مسكن، 8–10 طوارئ
- **يمنع مضاعفات** الألم غير المُعالج: ألم مزمن، اكتئاب، اضطرابات النوم
- **يحدد السبب** — واصفات الجودة تُميّز العصبي عن الوجداني
- **يُقيّم فعالية العلاج** — إعادة التقييم تحدد إذا نجح التدخل
- **يُحسّن رضا المريض** وجودة الحياة
- **يمنع التقصير في العلاج** — خاصة عند كبار السن وضعاف الإدراك
- **يمنع الإفراط في العلاج** — تجنّب الاعتماد على الأفيونات
- **التزام قانوني وأخلاقي** — إدارة الألم حق أساسي للمريض

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Cost of Poor Pain Assessment / تكلفة التقييم السيئ

Consequences of Poor Assessment / عواقب التقييم السيئ

Poor pain assessment leads to:

- Increased morbidity & mortality
- Prolonged hospital stay
- Development of chronic pain syndromes
- Delayed wound healing (↑ cortisol)
- Immunosuppression
- Psychological distress (anxiety, depression)
- Patient distrust of healthcare system
- Sleep deprivation
- Reduced quality of life

التقييم السيئ يؤدي إلى:

- زيادة الاعتلال والوفيات
- إطالة الإقامة في المستشفى
- تطوّر متلازمات ألم مزمن
- تأخر التئام الجروح (↑ كورتيزول)
- تثبيط المناعة
- ضائقة نفسية (قلق، اكتئاب)
- عدم ثقة المريض في النظام الصحي
- حرمان من النوم
- انخفاض جودة الحياة

Benefits of Accurate Assessment / فوائد التقييم الدقيق

EN:

- Improved patient outcomes (+40%)
- Reduced opioid consumption (30–50%)
- Faster recovery times
- Better patient satisfaction scores
- Reduced healthcare costs
- Compliance with Joint Commission standards

AR:

- تحسّن نتائج المرضى (+40%)
- تقليل استهلاك الأفيونات (30–50%)
- أوقات تعافي أسرع
- درجات رضا أفضل للمريض
- تقليل تكاليف الرعاية الصحية
- الالتزام بمعايير Joint Commission

Sources: RNAO (2013); WHO (2019); Joint Commission Standards (2017)

Key Message / الرسالة الأساسية

EN: Pain assessment is NOT an academic exercise! **Every question provides essential information about etiology and first steps to be undertaken to treat it.** (Powell et al., Pearls of Wisdom)

AR: تقييم الألم ليس تمريناً أكاديمياً! **كل سؤال يوفر معلومات أساسية عن السبب والخطوات الأولى للعلاج.**

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

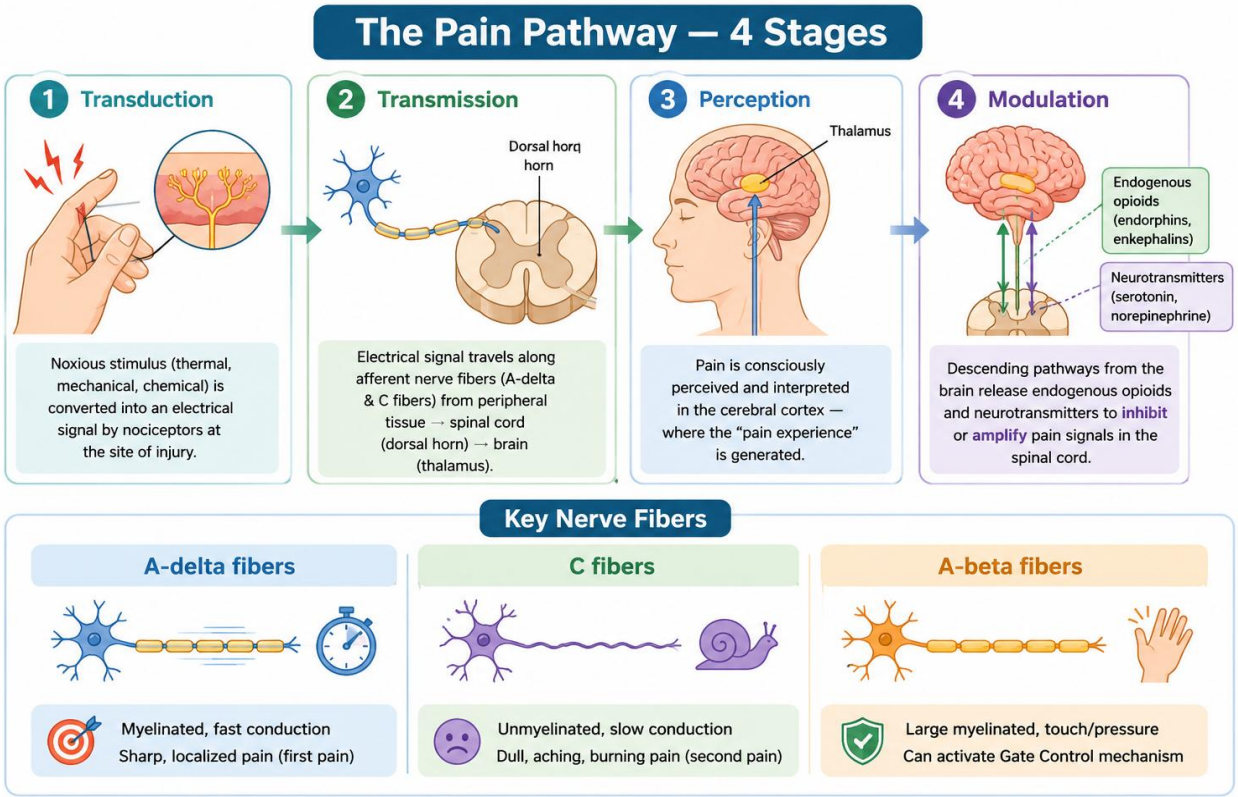
The Pain Pathway — 4 Stages / مسار الألم — 4 مراحل

The Pain Pathway consists of 4 sequential stages:

1. **Transduction:** Conversion of a noxious stimulus (thermal, mechanical, chemical) into an electrical signal by nociceptors (free nerve endings) at the site of injury.
2. **Transmission:** Propagation of the electrical signal along afferent nerve fibers (A-delta & C fibers) from the peripheral tissue → spinal cord (dorsal horn) → brain (thalamus).
3. **Perception:** Conscious awareness and interpretation of pain in the cerebral cortex — where the "pain experience" is generated.
4. **Modulation:** Descending pathways from the brain release endogenous opioids (endorphins, enkephalins) and neurotransmitters (serotonin, norepinephrine) to **inhibit** or **amplify** pain signals in the spinal cord.

Key Nerve Fibers:

- **A-delta fibers:** Myelinated, fast conduction, sharp/localized pain (first pain)
- **C fibers:** Unmyelinated, slow conduction, dull/aching/burning pain (second pain)
- **A-beta fibers:** Large myelinated, touch/pressure — can activate Gate Control mechanism



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

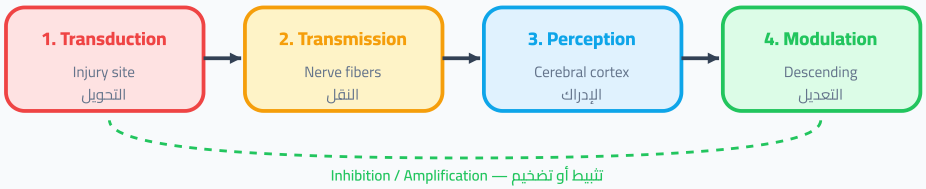
10 (cont.) — Arabic Pathway & Visualization

مسار الألم (عربي) والتصور المرئي (تابع)

مسار الألم يتكون من 4 مراحل متتالية:

1. **التحويل (Transduction):** تحويل المنبه الضار (حراري، ميكانيكي، كيميائي) إلى إشارة كهربائية بواسطة مستقبلات الألم (نهايات عصبية حرة) في موقع الإصابة.
2. **النقل (Transmission):** انتشار الإشارة الكهربائية عبر الألياف العصبية الواردة (A-delta وC) من النسيج المحيطي ← الحبل الشوكي (القرن الظهري) ← الدماغ (المهاد).
3. **الإدراك (Perception):** الوعي والتفسير الواعي للألم في القشرة الدماغية — حيث تتولد "تجربة الألم".
4. **التعديل (Modulation):** المسارات النازلة من الدماغ تُطلق الأفيونات الداخلية (إندورفينات، إنكيفالينات) والناقلات العصبية (سيروتونين، نورإبينفرين) لـ**تثبيط** أو **تضخيم** إشارات الألم في الحبل الشوكي.

Pain Pathway Visualization / تصور مسار الألم



A-delta fibers
Myelinated, fast, sharp pain

C fibers
Unmyelinated, slow, dull/burning

A-beta fibers
Touch/pressure, gate control

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Essential Pain Terminology / المصطلحات الأساسية للألم

Term / المصطلح	Definition (EN)	التعريف (AR)
Nociception	Neural process of encoding noxious stimuli	استقبال المنبهات الضارة
Nociceptor	Sensory receptor that responds to painful stimuli	مستقبل عصبي حسي للألم
Allodynia	Pain from non-painful stimulus (e.g., light touch)	ألم من منبه غير مؤلم
Hyperalgesia	Increased sensitivity/response to painful stimulus	فرط الحساسية للألم
Hypoalgesia	Decreased sensitivity to painful stimulus	نقص الحساسية للألم
Analgesia	Absence of pain in response to stimulus	غياب الألم
Paresthesia	Abnormal sensation (tingling, pins and needles)	إحساس غير طبيعي (تنميل)
Dysesthesia	Unpleasant abnormal sensation	إحساس غير طبيعي مزعج
Neuralgia	Pain in the distribution of a nerve	ألم عصبي بمسار العصب
Neuropathy	Disturbance of function/pathological change in a nerve	اعتلال عصبي
Radiculopathy	Pain radiating along a nerve root	ألم جذري
Causalgia	Burning pain with sympathetic dysfunction	ألم حارق مع خلل ودي
Somatic pain	Pain from skin, muscle, bone, joint	ألم جسدي
Visceral pain	Pain from internal organs	ألم حشوي
Referred pain	Pain perceived at a location other than the site	ألم مُحال لمكان بعيد
Breakthrough pain	Sudden pain despite regular analgesia	ألم مباغت رغم المسكن

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Q PQRSTU — Standard Assessment Format / نظام التقييم المعياري

PQRSTU Assessment Format (Bates, 1991; Powell et al.):

The critical components of the pain assessment process include a determination of its location, description, intensity, duration, alleviating and aggravating factors, and its impact upon the patient's life. These components are most commonly embodied in the **PQRST** approach:

Letter	Full Term	Question to Ask	بالعربي
P	Provocative / Palliative	What causes the pain? What makes it better/worse?	ما الذي يسبب/يخفف الألم؟
Q	Quality	What does the pain feel like? Sharp? Dull? Stabbing? Burning? Crushing?	كيف يشعر الألم؟
R	Region / Radiation	Where is the pain? Does it radiate? Where to?	أين الألم؟ إلى أين ينتشر؟
S	Severity	How severe is the pain? (Rate 0–10)	ما شدة الألم؟
T	Time / Temporal	When did it start? Continuous or intermittent? How long?	متى بدأ؟ متى ينتهي؟
U	Understanding / Impact	How is the pain affecting you? Your life?	كيف يؤثر الألم عليك؟

? Additional Questions at First Assessment / أسئلة إضافية للتقييم الأول

EN: At the patient's first assessment, pain assessment should be part of a wider comprehensive assessment including: history of pain, patient's diagnosis and past medical history (diabetes, arthritis), history of surgical operations or medical disorders, recent trauma, cardiovascular/pulmonary/stroke/hypertension history, current medications, allergies, pain on deep inhalation, psychological status (depression, dementia, anxiety), and functional status including activities of daily living.

Source: Powell et al., Guide to Pain Management, Chapter 10 (IASP).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

12 (cont.) — OPQRST & OLDCARTS Comparison مقارنة OPQRST وOLDCARTS (تابع)

OPQRST Format

Letter	Term
O	Onset (متى بدأ؟)
P	Provocation (يزيده؟)
Q	Quality (كيف يشعر؟)
R	Radiation (ينتشر؟)
S	Severity (0–10)
T	Time (متى؟)

OLDCARTS Format

Letter	Term
O	Onset (متى بدأ؟)
L	Location (أين؟)
D	Duration (لكم مدة؟)
C	Character (كيف؟)
A	Aggravating (يزيده؟)
R	Relieving (يخففه؟)
T	Timing (متى؟)
S	Severity (0–10)

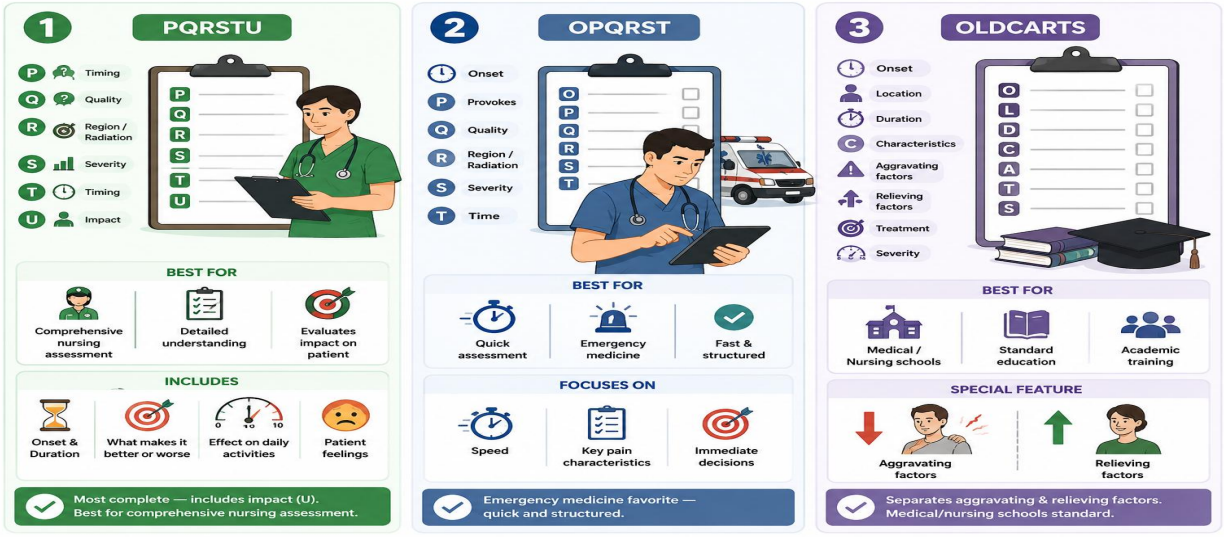
Which System to Use? / أي نظام تستخدم؟

EN:

- **PQRSTU:** Most complete — includes impact assessment (U). Best for comprehensive nursing assessment.
- **OPQRST:** Emergency medicine favorite — quick and structured.
- **OLDCARTS:** Medical/nursing schools standard — separates aggravating & relieving factors.

AR:

- **PQRSTU:** الأكثر شمولاً — يشمل تقييم التأثير (U).
- **OPQRST:** المفضل في طب الطوارئ — سريع ومنظم.
- **OLDCARTS:** معيار كليات التمريض والطب.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Assessment of Pain — Subjective Data / تقييم الألم — البيانات الذاتية

Assessment of pain includes: Subjective data and Objective data. (Devisri, R.)

Subjective Data has 4 key components:

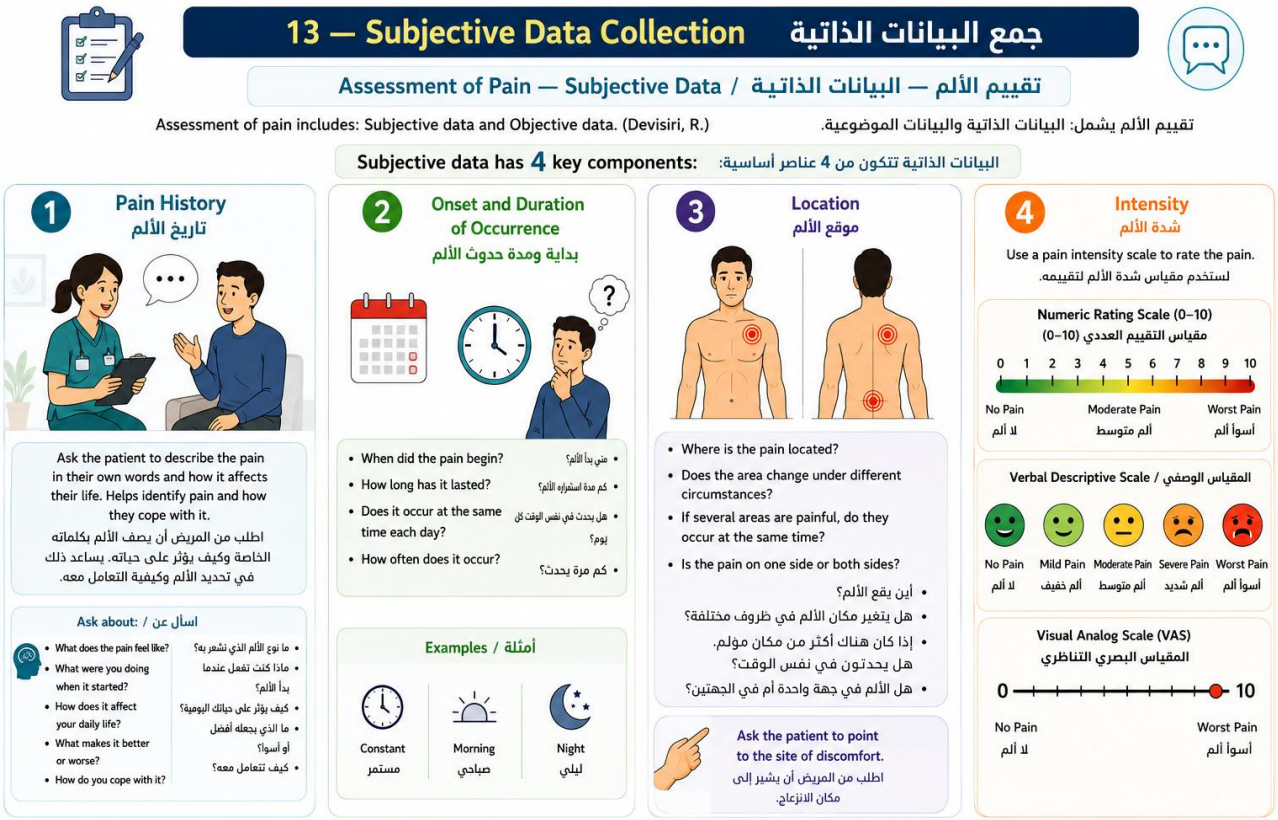
1. Pain History: While taking pain history, the nurse must provide an opportunity for clients to express in their own words how they view the pain and their situation. This will help the nurse to identify patient pain and how to cope with it.

2. Onset and Duration of Occurrence: When did pain begin? How long has it lasted? Does it occur at the same time each day? How often does it occur?

3. Location: In which area is it felt? Do the areas differ under different circumstances? If several parts of the body are painful, do the pains occur simultaneously? Is pain unilateral or bilateral? Ask the individual to point to the site of discomfort.

4. Intensity: Use of a pain intensity scale is an easy and reliable method of determining the client's pain intensity. Most scales are either 0 to 5 or 0 to 10. Currently used scales are: Numerical scale, Descriptive scale, Visual analog scale.

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

يشمل تقييم الألم: البيانات الذاتية والبيانات الموضوعية.

البيانات الذاتية لها 4 مكونات رئيسية:

1. تاريخ الألم: عند أخذ تاريخ الألم، يجب على الممرض أن يوفر للعميل الفرصة للتعبير بكلماته الخاصة عن كيفية رؤيته للألم ووضعه. هذا يساعد الممرض على تحديد ألم المريض وكيفية التعامل معه.

2. بداية ومدة الحدوث: متى بدأ الألم؟ كم استمر؟ هل يحدث في نفس الوقت كل يوم؟ ما مدى تكراره؟

3. الموقع: في أي منطقة يُشعر به؟ هل تختلف المناطق تحت ظروف مختلفة؟ إذا كانت عدة أجزاء من الجسم مؤلمة، هل تحدث الآلام في نفس الوقت؟ هل الألم في جانب واحد أم في الجانبين؟ اطلب من الشخص أن يشير إلى موقع الانزعاج.

4. الشدة: استخدام مقياس شدة الألم هو طريقة سهلة وموثوقة لتحديد شدة ألم العميل. معظم المقاييس إما 0 إلى 5 أو 0 إلى 10. المقاييس المستخدمة حالياً هي: المقياس الرقمي، المقياس الوصفي، مقياس التناظر البصري.

Key Questions for Subjective Data / الأسئلة الرئيسية للبيانات الذاتية

PATTERN — Onset & Duration:

- When did the pain start?
- How long does it last?
- How often does it occur?

النمط — البداية والمدة:

- متى بدأ الألم؟
- كم يستمر؟
- ما مدى تكراره؟

AREA — Location:

- Where exactly is the pain?
- Does it move or stay in one place?
- Is it unilateral or bilateral?

المنطقة — الموقع:

- أين الألم بالضبط؟
- هل يتحرك أم يبقى في مكان واحد؟
- هل هو في جانب واحد أم الجانبين؟

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Objective Data Collection / جمع البيانات الموضوعية

Objective Assessment includes 2 major components:

1. BEHAVIORAL EFFECTS:

- Assess **verbalization, vocal response, facial and body movements & social interaction**
- **Facial expression** is often the 1st indication of pain & may be the only manifestation
- Vocalizations like **moaning, groaning, crying, grunting, screaming** are associated with pain

2. PHYSIOLOGICAL RESPONSES:

- Vary with the origin and duration of pain
- Early in onset of acute pain, the **sympathetic nervous system** is stimulated
- Results in **increased blood pressure, pulse rate, respiration, pallor, diaphoresis, and pupil dilation**

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.

✦ ✦ ✦

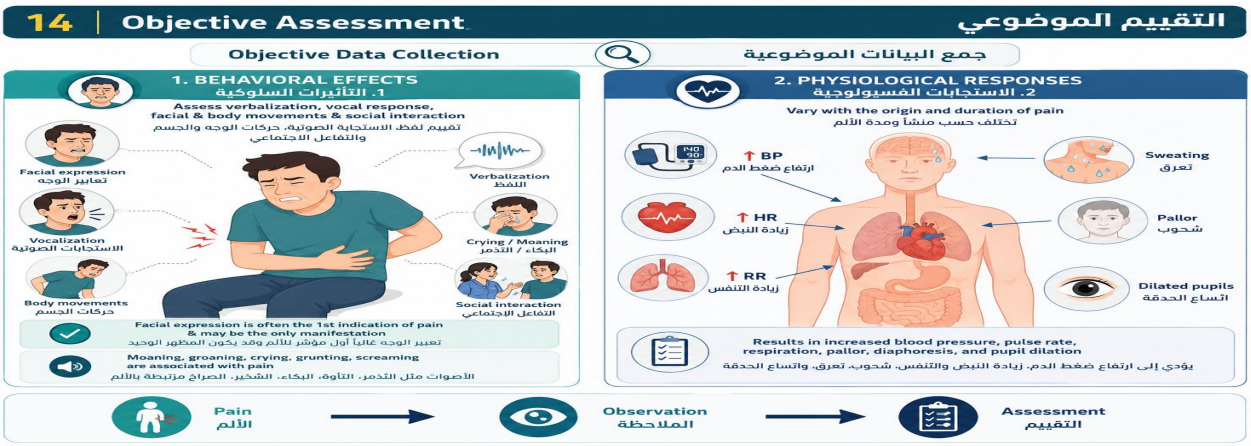
يشمل التقييم الموضوعي مكونين رئيسيين:

1. التأثيرات السلوكية:

- تقييم **اللفظ، الاستجابة الصوتية، حركات الوجه والجسم والتفاعل الاجتماعي**
- **تعبير الوجه** غالباً أول مؤشر للألم وقد يكون المظهر الوحيد
- الأصوات مثل **الأنين، التأوه، البكاء، الشخير، الصراخ** ترتبط بالألم

2. الاستجابات الفسيولوجية:

- تختلف حسب منشأ ومدة الألم
- في بداية الألم الحاد يُثار **الجهاز العصبي الودي**
- يؤدي إلى **ارتفاع ضغط الدم، زيادة النبض والتنفس، شحوب، تعرق، واتساع الحدقة**



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

14 (cont.) — Subjective vs. Objective Comparison | مقارنة البيانات الذاتية والموضوعية (تابع)

Subjective vs. Objective Data Comparison

Component	Subjective (Patient's Report)	Objective (Nurse's Observation)
Source	Patient tells you directly	Nurse observes/measures
Examples	"It hurts here", "It's a 7/10", "Burning pain"	Grimacing, guarding, tachycardia, HTN
Tools	Pain scales (NRS, VAS, Wong-Baker)	Vital signs, behavioral scales (CPOT, FLACC)
Reliability	Gold standard when patient can communicate	Essential when patient cannot self-report
Examples of Signs	Location, quality, timing, aggravating factors	Facial expression, body movements, vital signs

★ Clinical Application / التطبيق السريري

EN:

- Always start with **subjective data** if patient can communicate
- Use **objective data** to validate and support subjective report
- In non-verbal patients (ICU, dementia, infants), **objective data becomes primary**
- Discrepancy between subjective/objective → investigate further, don't dismiss patient
- Document BOTH types of data in nursing notes

AR:

- ابدأ دائماً بـ**البيانات الذاتية** إذا كان المريض يستطيع التواصل
- استخدم **البيانات الموضوعية** للتحقق ودعم التقرير الذاتي
- في المرضى غير اللفظيين (ICU، خرف، رضّع)، **البيانات الموضوعية تصبح أساسية**
- الاختلاف بين الذاتية/الموضوعية ⇐ حقّق أكثر، لا تُهمل المريض
- وثّق كلا النوعين في الملاحظات التمريضية

⚠ Important Warning / تحذير مهم

EN: Evidence suggests that **health care providers' observational pain report cannot be assumed to be an accurate indicator of the patient's pain**. Always trust the patient's self-report as the gold standard when they can communicate. (Powell et al.)

AR: الأدلة تشير إلى أن **تقرير الممرض الملاحظ لا يمكن افتراضه مؤشراً دقيقاً لألم المريض**. ثق دائماً في تقرير المريض الذاتي كمعيار ذهبي.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Types of Pain Scales / أنواع مقاييس الألم

Types of Pain Scales (Devisri, R.):

1. **DESCRIPTIVE SCALE (Verbal Rating Scale)**
2. **NUMERICAL SCALE (Numerical Rating Scale - NRS)**
3. **VISUAL ANALOG SCALE (VAS)**

1. Numerical Rating Scale (NRS):

- A numerical rating scale with the range of 0 to 10 is another type of pain scale that is used.
- The word **'no pain'** appears by "0" and **"worst pain possible"** is found by "10".
- Patients are asked to choose a number from 0 to 10 that best reflects his/her level of pain.

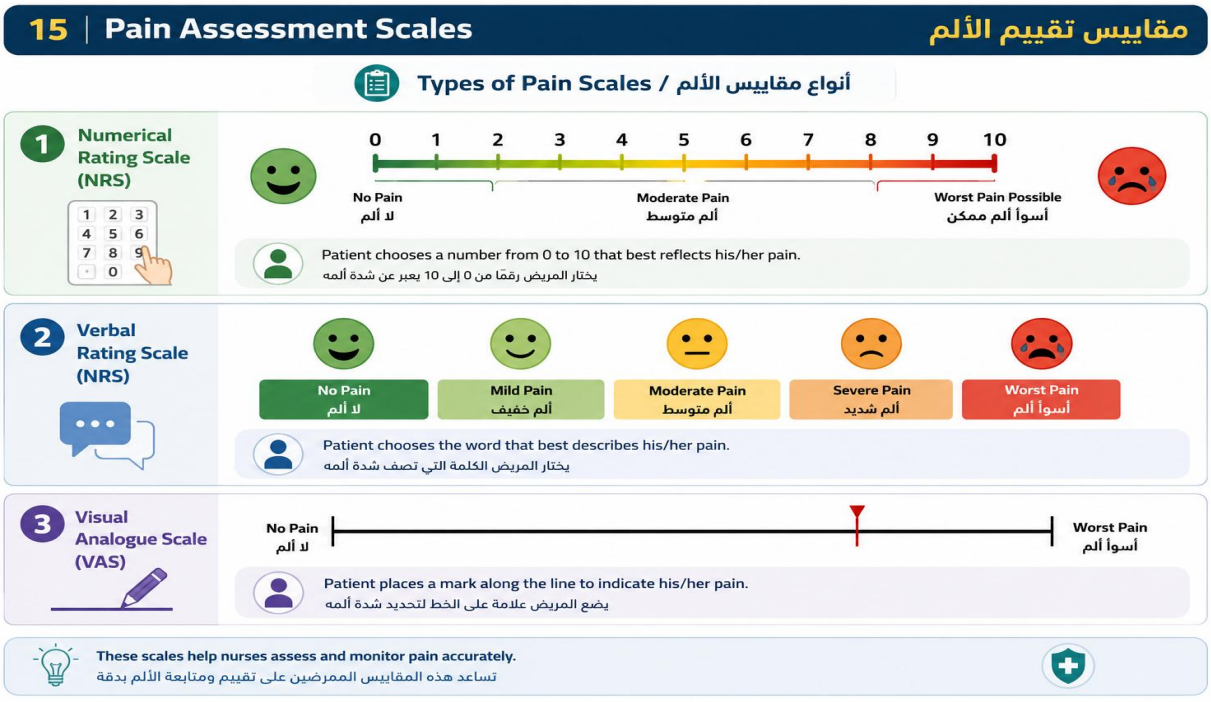
2. Verbal Rating Scale (VRS):

- Verbal pain scales, as name suggests, use words to describe pain.
- Words such as **no pain, mild pain, moderate pain, and severe pain** are used to describe pain levels.

3. Visual Analogue Scale (VAS):

- VAS uses a vertical or horizontal line with words that convey **"no pain"** at one end and **"worst pain"** at the opposite end.
- Patient is asked to place a mark along the line that indicates his/her level of pain.

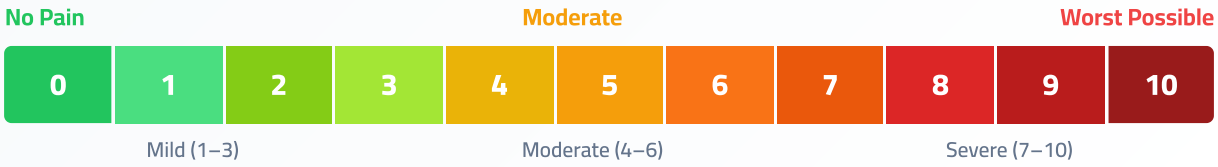
Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

15 (cont.) — Visual Representation of Scales التمثيل المرئي للمقاييس (تابع)

Numerical Rating Scale (NRS) 0–10



Verbal Descriptor Scale (VDS)



Visual Analogue Scale (VAS) 0–100mm



Patient marks a point on the 10cm line indicating their pain level

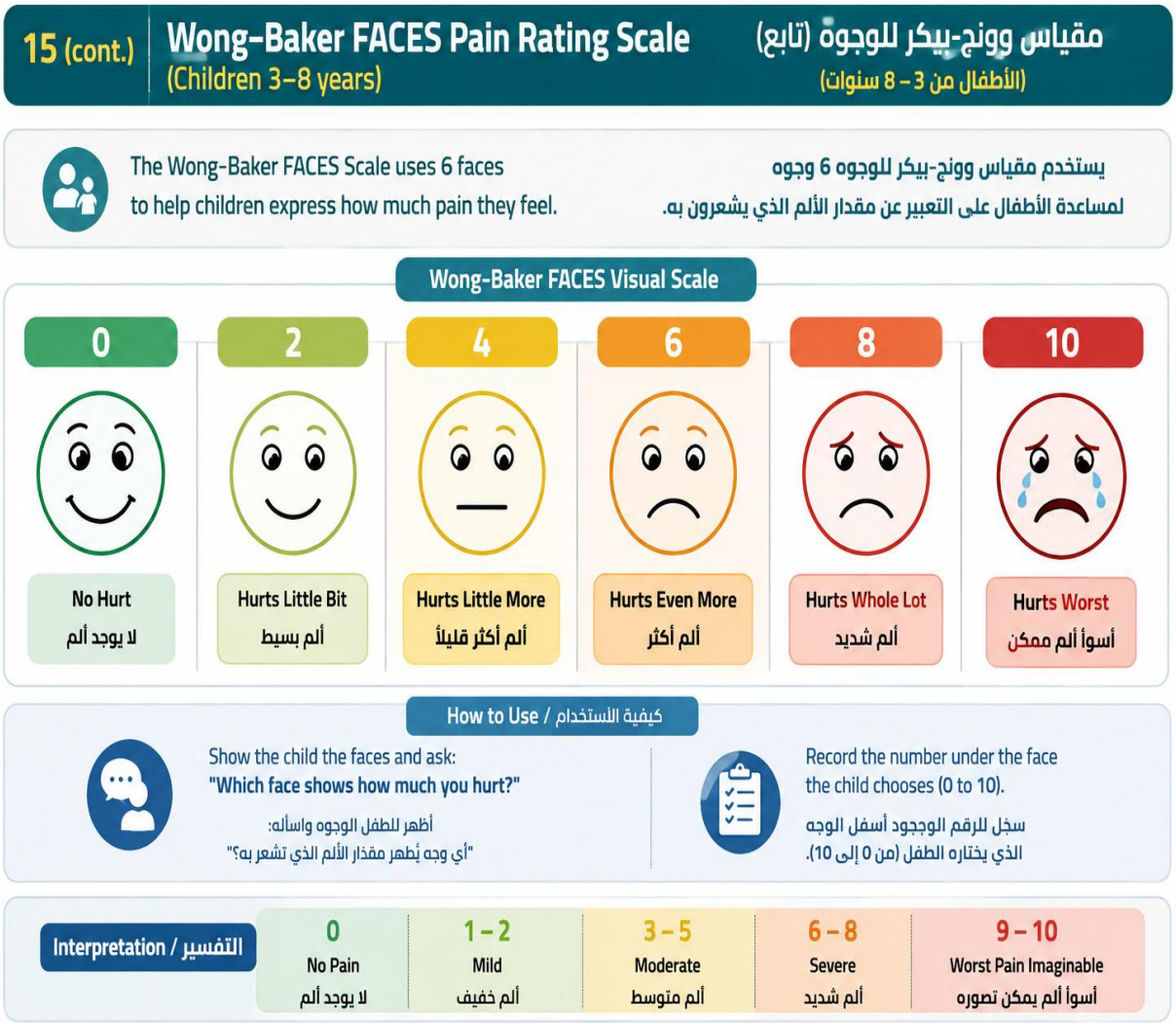
RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Wong-Baker FACES Scale (Children 3–8 yr)

With the Wong-Baker pain scale, six faces are used that are numbered 0 to 5 underneath:

- **Face 0:** A happy face
- **Face 2:** Still smiling
- **Face 4:** Not smiling or frowning
- **Face 6:** Starting to frown
- **Face 8:** Definitely frowning
- **Face 10:** Crying

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management. Wilson & Hockberry (2008).



RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Detailed Adult Tools / الأدوات التفصيلية للبالغين

Detailed Description of Adult Pain Assessment Tools (from Powell et al., IASP):

1. Visual Analogue Scale (VAS):

- Uses a 10-cm-long horizontal line, anchored by "No pain" and "Worst pain imaginable"
- Patient makes a mark to indicate current pain perception
- **Advantages:** Quick, simple, easy to score and compare, validated extensively, considered one of the best tools for variations
- **Disadvantages:** Highly sensitive to changes; some adults find too abstract; problematic for cognitive dysfunction, postoperative, visual impairment

2. Numerical Rating Scale (NRS):

- Patient rates pain intensity on a scale usually 0 (No pain) to 10 (Worst pain imaginable)
- Can be administered verbally — overcomes visual/physical impairment issues
- **Advantages:** Quick, simple, easy to document and compare, well validated, can be translated, detects treatment effects, easy to teach
- **Disadvantages:** Some patients unable to complete with verbal instructions alone; decreased reliability at age extremes and with non-verbal/cognitively impaired

3. Verbal Descriptor Scale (VDS):

- Patient chooses one of descriptors: "No pain," "Mild pain," "Moderate pain," "Severe pain," "Very severe pain," "Worst pain possible"
- **Advantages:** Quick, simple, easily comprehended, well validated, intuitively preferred
- **Disadvantages:** Depends on language interpretation; challenging across cultures; problematic for very young/old, cognitively impaired, illiterate

Source: Powell, R.A. et al. Guide to Pain Management in Low-Resource Settings (IASP). Appendix 2.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

أدوات تقييم الألم للبالغين (من Powell et al.):

مقياس التناظر البصري (VAS): خط أفقي 10 سم، من "لا ألم" إلى "أسوأ ألم يمكن تخيله". المريض يضع علامة. **مميزاته:** سريع، بسيط، صادق، قابل للمقارنة. **عيوبه:** حساس جداً للتغيرات، صعب على بعض المرضى.

المقياس الرقمي (NRS): من 0 إلى 10. يمكن إعطاؤه شفهياً. **مميزاته:** سهل التوثيق والمقارنة، قابل للتعلم، يكتشف تأثير العلاج. **عيوبه:** قد لا يستطيع بعض المرضى إكماله شفهياً.

مقياس الوصف اللفظي (VDS): يختار المريض من كلمات (لا ألم، خفيف، متوسط، شديد، شديد جداً، أسوأ ما يمكن تخيله). **مميزاته:** بسيط، مفهوم بسهولة. **عيوبه:** يعتمد على تفسير اللغة، صعب عبر الثقافات المختلفة.

المقياس الأفريقي للرعاية (APCA African POS): مقياس متعدد الأبعاد (0-5) يضم الألم ضمن عناصر أخرى. يُستخدم في الرعاية التلطيفية. يُروج له من قبل WHO. يمكن إكماله باستخدام "مقياس اليد" (من قبضة مغلقة = لا ألم إلى 5 أصابع مفتوحة = أسوأ ألم).

مقياس الألم في الخرف المتقدم (PAINAD): أداة ملاحظة لمرضى الخرف الذين لا يستطيعون التواصل. يتكون من 5 عناصر (التنفس، الأصوات السلبية، تعبير الوجه، لغة الجسم، التهدئة)، كل عنصر 0-2، المجموع 0-10.

Tools Comparison Summary / ملخص مقارنة الأدوات

Tool	Best For	Range	Drawback
VAS	Adults, literate	0-100mm	Abstract; visual impairment
NRS	Adults, all levels	0-10	Age extremes unreliable
VDS	Adults, low literacy	6 words	Language/culture dependent
APCA POS	Palliative care	0-5	Requires staff training
PAINAD	Dementia / non-verbal	0-10	Proxy indicators only

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

When Must Pain Be Assessed? / متى يجب تقييم الألم؟

Indications for Pain Assessment include:

- Every clinical encounter (per Joint Commission standards)
- Before and after invasive procedures (IV insertion, wound care, dressing changes)
- Post-operatively (after surgery, after anesthesia recovery)
- Before and after administration of analgesic medications
- When patient reports discomfort or shows behavioral signs
- During routine nursing rounds (minimum q4h in hospital)
- When patient has a history of chronic pain condition
- When patient has risk factors: anxiety, depression, previous trauma
- In ICU: continuously for intubated/non-verbal patients using CPOT/BPS
- During palliative care and end-of-life care
- Before and after physical therapy or rehabilitation sessions
- When patient is admitted with acute trauma or injury

✦ ✦ ✦

دواعي تقييم الألم تشمل:

- كل زيارة سريرية (وفق معايير Joint Commission)
- قبل وبعد الإجراءات الغازية
- بعد العمليات الجراحية (بعد التعافي من التخدير)
- قبل وبعد إعطاء مسكنات الألم
- عندما يبلغ المريض عن عدم ارتياح أو يظهر علامات سلوكية
- خلال الجولات التمريضية الروتينية (كل 4 ساعات كحد أدنى)
- عندما يكون لدى المريض تاريخ ألم مزمن
- عندما يكون المريض عرضة لعوامل الخطر: قلق، اكتئاب، صدمة سابقة
- في ICU: باستمرار للمرضى على التنفس الصناعي غير اللفظيين
- خلال الرعاية التلطيفية والرعاية في نهاية الحياة
- قبل وبعد جلسات العلاج الطبيعي
- عند دخول المريض بسبب صدمة حادة أو إصابة

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Contraindications & Assessment Challenges / الموانع والتحديات

Contraindications / Challenges for Pain Assessment:

- **Patient unable to communicate** (intubated, unconscious, severe cognitive impairment)
- **Language barriers** — patient and provider speak different languages
- **Cultural differences** in pain expression (some cultures suppress pain expression)
- **Age-related challenges:** neonates need behavioral observation only; toddlers may show regressive behavior; preschoolers may see pain as punishment; adolescents may deny pain in front of peers
- **Dementia / Alzheimer's:** unable to self-report; relies on PAINAD observation
- **Psychological conditions:** depression, anxiety, PTSD may alter pain reporting
- **Medication effects:** analgesics already administered; sedation affecting response
- **Time constraints:** emergency situations requiring rapid assessment

✦ ✦ ✦

الموانع والتحديات لتقييم الألم:

- **عدم قدرة المريض على التواصل** (على التنفس الصناعي، فاقد الوعي، ضعف إدراكي شديد)
- **الحواجز اللغوية** — المريض ومقدم الرعاية يتحدثان لغات مختلفة
- **الفروق الثقافية** في تعبير الألم (بعض الثقافات تكبت التعبير)
- **تحديات حسب العمر:** حديثو الولادة يحتاجون الملاحظة السلوكية فقط، الأطفال الصغار قد يظهرون سلوكاً متراجعاً، ما قبل المدرسة قد يرون الألم عقاباً، المراهقون قد ينكرون الألم أمام الأقران
- **الخرف / الزهايمر:** عدم القدرة على التقرير الذاتي، يعتمد على ملاحظة PAINAD
- **الحالات النفسية:** الاكتئاب، القلق، PTSD قد يغيران التقرير
- **تأثيرات الأدوية:** مسكنات سابقة، تخدير يؤثر على الاستجابة
- **قيود الوقت:** حالات طوارئ تتطلب تقييماً سريعاً

⚠ Important / مهم

EN: For patients with dementia, the principal rule is to **ask for pain**. Among those with sufficient cognitive functioning, increase text size, include relatives, and avoid mental overload.

AR: لمرضى الخرف، القاعدة الرئيسية هي **سؤالهم عن الألم**. زد حجم النص، اشمل الأقارب، تجنّب الإرهاق الذهني.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Equipment Preparation / تحضير الأدوات

Preparation of Equipment (from PPT — Devisri, R.):

1. **Pain Scale** — Appropriate scale for patient age/development/comprehension (NRS, VAS, Wong-Baker, FLACC, CPOT, PAINAD)
2. **Privacy Screen** — As needed for patient comfort and confidentiality during assessment
3. **Patient Case Sheet** — Documentation form for recording pain assessment findings
4. **Good Lighting** — Ensure presence of easy lighting for accurate observation of facial/body expressions
5. **Body Diagram** — For patient to indicate primary and multiple pain locations

تحضير الأدوات:

- **مقياس الألم:** المناسب لعمر المريض ومستواه التطوري وفهمه
- **ستار الخصوصية:** حسب الحاجة لراحة المريض وسرية التقييم
- **ملف المريض:** نموذج توثيق نتائج تقييم الألم
- **إضاءة جيدة:** لضمان ملاحظة دقيقة لتعبيرات الوجه والجسم
- **مخطط الجسم:** ليشير المريض لمواقع الألم الرئيسية

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

20 — Nursing Procedure: 8 Steps

الإجراء التمريضي: 8 خطوات

Nursing Procedure for Pain Assessment إجراء تقييم الألم

1		Explain	Explain the procedure to the patient.
2		Wash Hands & Gloves	Wash hands and wear gloves.
3		Ensure Privacy	Provide privacy.
4		Ensure Good Lighting	Ensure adequate lighting.
5		Assess Pain (PQRSTU)	Ask about pain using PQRSTU.
6		Check Other Measures	Check other signs and avoid duplication.
7		Document Pain	Record information clearly.
8		Perform Care & Hygiene	Provide care and prevent infections.



Good assessment leads to better care and pain relief. تقييم جيد يعني رعاية أفضل وتخفيف الألم.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Recording, Reporting & Documentation / التوثيق والتسجيل

★ Recording & Reporting

Record and report the **character of pain before intervention**, therapies used, and patient's response. This creates a complete clinical picture for continuity of care.

Source: Devisri, R.

★ التسجيل والتقرير

سجّل وبلّغ عن **طبيعة الألم قبل التدخل**، العلاجات المستخدمة، واستجابة المريض. هذا يخلق صورة سريرية كاملة لاستمرارية الرعاية.

Sample Documentation / نموذج التوثيق

Patient: [Name] | **Date:** [Date] | **Time:** [Time]
Pain Assessment:
- **Location:** Lumbar region of back (constant)
- **Quality:** Dull, aching (not radiating)
- **Severity:** 6/10 – Moderate pain
- **Timing:** Continuous; increases with mild physical activity
- **Aggravating:** Physical activity
- **Relieving:** Hot water bag applied
- **Intervention:** T. Dolo 650mg administered per doctor's order
- **Reassessment:** To be done at 30 min (oral) / 15 min (IV)

Note: Pain does not radiate; increases with mild activity.

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management (Sample Documentation).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

21 — Scientific Rationales التسويغ العلمي

Why We Do What We Do / لماذا نفعل ما نفعله

1. **Explain procedure** → Reduces anxiety, promotes cooperation, and builds therapeutic rapport. Anxious patients report higher pain scores (biopsychosocial model).

2. **Hand hygiene** → Prevents healthcare-associated infections (HAIs). CDC reports proper hand hygiene reduces HAIs by up to 50%.

3. **Privacy** → Respects patient dignity, encourages honest pain reporting. Studies show patients underreport pain in public settings.

4. **Good lighting** → Facial expression is often the 1st indication of pain and may be the ONLY manifestation in non-verbal patients (Devisri, R.).

5. **Use PQRSTU** → Systematic approach ensures no critical aspect is missed. Bates (1991) established these as critical components; Powell et al. (IASP) confirms use in low-resource settings.

6. **Ask about home remedies** → Prevents medication duplication, identifies non-pharmacological effectiveness, informs multimodal analgesia plan (WHO 2019).

7. **Document accurately** → Creates legal record, ensures continuity of care, allows comparison over time. Joint Commission requires reassessment within 30–60 min of intervention.

8. **Reassessment timing** → IV analgesics peak in 15 min; oral analgesics peak in 30 min. Reassessment at these times determines efficacy and need for adjustment.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Practical Clinical Tips / نصائح سريرية عملية

Practical Tips (EN):

- **Believe the patient** — never dismiss pain report
- Assess pain at every vital signs check (5th vital sign)
- Reassess after each intervention (15 min IV / 30 min PO)
- Use **same scale consistently** for reliable comparison
- Watch facial expression — it's often the FIRST sign
- Ask open-ended questions: "Tell me about your pain"
- Show empathy — therapeutic communication reduces pain perception
- Include patient in pain management plan
- Use body diagrams for multiple pain sites
- Consider cultural factors in pain expression
- Combine pharmacological + non-pharmacological approaches
- Document specific descriptors used by patient

نصائح عملية (AR):

- **صدّق المريض** — لا تُهمل تقرير الألم أبداً
- قيّم الألم مع كل قياس علامات حيوية (العلامة الخامسة)
- أعد التقييم بعد كل تدخل (15 دقيقة IV / 30 دقيقة فموي)
- استخدم **نفس المقياس باستمرار** للمقارنة الموثوقة
- راقب تعبير الوجه — غالباً أول علامة
- اسأل أسئلة مفتوحة: "احكيلي عن ألمك"
- أظهر التعاطف — التواصل العلاجي يقلل إدراك الألم
- اشرك المريض في خطة إدارة الألم
- استخدم مخططات الجسم لمواقع ألم متعددة
- ضع في الاعتبار العوامل الثقافية في تعبير الألم
- ادمج المسكنات الدوائية وغير الدوائية
- وثّق الكلمات الوصفية التي يستخدمها المريض

★ Pearl of Wisdom / لؤلؤة الحكمة

EN: Pain assessment is NOT an academic exercise! Every question potentially provides essential information about the etiology of pain and certain first steps to be undertaken to treat it. (Powell et al., Pearls of Wisdom, IASP)

AR: تقييم الألم ليس تمريناً أكاديمياً! كل سؤال يوفر معلومات أساسية عن سبب الألم والخطوات الأولى للعلاج.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Complete Pain Documentation Requirements / متطلبات التوثيق الكامل

Every pain assessment must document:

- **Date & Time** of assessment
- **Location** (specific anatomical site, use body diagram if multiple)
- **Quality/Character** (patient's own words: burning, aching, sharp, dull)
- **Intensity** (numerical score using validated tool: NRS 0–10)
- **Duration** (continuous, intermittent, episodic)
- **Onset** (sudden vs. gradual)
- **Aggravating & Relieving factors**
- **Associated symptoms** (nausea, sweating, restlessness)
- **Impact on function** (sleep, ADLs, mood)
- **Interventions performed** (pharm & non-pharm)
- **Response to intervention** (reassessment score after 15-30 min)
- **Patient education provided**
- **Nurse signature**

Source: Joint Commission Standards (2017); RNAO (2013) Best Practice Guidelines.

✦ ✦ ✦

يجب توثيق كل تقييم للألم بما يشمل:

- **التاريخ والوقت** للتقييم
- **الموقع** (المكان التشريحي المحدد، استخدم مخطط الجسم إذا كان متعدداً)
- **الجودة/الطبيعة** (كلمات المريض: حارق، مؤلم، حاد، خفيف)
- **الشدة** (درجة رقمية باستخدام أداة معتمدة: NRS 0–10)
- **المدة** (مستمر، متقطع، نوبات)
- **البداية** (مفاجئ أم تدريجي)
- **العوامل المزيدة والمخففة**
- **الأعراض المصاحبة** (غثيان، تعرق، تململ)
- **التأثير على الوظيفة** (النوم، الأنشطة اليومية، المزاج)
- **التدخلات المُنفذة** (دوائية وغير دوائية)
- **الاستجابة للتدخل** (درجة إعادة التقييم بعد 15-30 دقيقة)
- **التثقيف المُقدم للمريض**

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Original Sample Documentation (Devisri, R.)

Original Sample from PPT (Devisri, R.):

"Patient expressed constant pain at the lumbar region of the back. He/she said that it does not radiate but increases even with mild physical activity. The level of pain was assessed using numerical and descriptive pain scale. The pain score was **6/10** and the patient expressed **moderate level of pain**. Hot water bag applied and **T. Dolo 650mg administered as per doctor's order**."

Source: Devisri, R. PPT Pain Assessment & Management, Karpaga Vinayaga College of Nursing.

Analysis of Sample / تحليل النموذج

Element / العنصر	Documented / الموثّق
Location	Lumbar region of back
Character	Constant pain (does not radiate)
Aggravating	Mild physical activity
Assessment tool	Numerical + Descriptive pain scale
Severity	6/10 — Moderate pain
Non-pharm intervention	Hot water bag applied
Pharm intervention	T. Dolo 650mg (Paracetamol)
Order source	As per doctor's order

ترجمة نموذج التوثيق:

"عبّر المريض عن ألم مستمر في المنطقة القطنية من الظهر. أفاد بأن الألم لا ينتشر لكنه يزداد حتى مع النشاط الجسدي البسيط. تم تقييم مستوى الألم باستخدام المقياس الرقمي والوصفي. كانت درجة الألم **6/10** وعبّر المريض عن مستوى ألم **متوسط**. تم وضع كمادة ماء ساخنة وإعطاء **Dolo 650mg قرص وفقاً لأمر الطبيب**."

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Infection Control During Pain Assessment / مكافحة العدوى

Infection Control Measures:

- **Hand hygiene BEFORE and AFTER** patient contact (WHO 5 Moments of Hand Hygiene)
- Use **alcohol-based hand rub** if hands not visibly soiled
- Wash hands with soap & water if visibly soiled or after contact with body fluids
- **Wear gloves** if contact with wounds, dressings, or body fluids expected
- Change gloves between patients — NEVER reuse
- **Clean pain assessment tools** (rulers, cards, iPads) between patients
- Follow **standard precautions** for all patients regardless of diagnosis
- Use **additional precautions** (contact, droplet, airborne) as needed
- Dispose of gloves and PPE properly in designated bins
- Perform hand hygiene **even when gloves are worn**

✦ ✦ ✦

إجراءات مكافحة العدوى:

- **نظافة الأيدي قبل وبعد** ملامسة المريض (5 لحظات WHO لنظافة الأيدي)
- استخدم **مطهر يدين كحولي** إذا لم تكن اليدين ملوثة بشكل واضح
- اغسل الأيدي بالماء والصابون إذا كانت ملوثة أو بعد ملامسة سوائل الجسم
- **ارتد القفازات** إذا كان متوقعاً ملامسة الجروح أو الضمادات أو سوائل الجسم
- غيّر القفازات بين المرضى — لا تُعِد استخدامها أبداً
- **نظف أدوات تقييم الألم** (المساطر، البطاقات، iPads) بين المرضى
- اتبع **الاحتياطات المعيارية** لجميع المرضى بغض النظر عن التشخيص
- استخدم **احتياطات إضافية** (تلامس، رذاذ، محمول جواً) حسب الحاجة
- تخلص من القفازات وPPE بشكل صحيح في الحاويات المخصصة
- نفذ نظافة اليدين **حتى عند ارتداء القفازات**

⚠ Key Statistic / إحصائية مهمة

EN: Proper hand hygiene reduces healthcare-associated infections by **up to 50%** (CDC). Pain assessment tools are commonly overlooked as fomites — disinfect between patients!

AR: نظافة اليدين السليمة تُقلل العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية **حتى 50%** (CDC). أدوات تقييم الألم غالباً ما تُهمل كناقلات للعدوى — طهّرها بين المرضى!

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

26 — Safety Precautions | احتياطات السلامة

Patient & Nurse Safety / سلامة المريض والممرض

Patient Safety (EN):

- **Verify patient identity** (2 identifiers: name + DOB)
- Assess mental status before asking pain questions
- Position patient comfortably during assessment
- Ensure call bell within reach after assessment
- Avoid causing additional pain during examination
- Support painful areas during patient movement
- Monitor for adverse effects of analgesics (respiratory depression, sedation)
- Check for allergies before medication administration
- Follow the "Rights of Medication Administration"
- Watch for signs of medication interactions

سلامة المريض (AR):

- **تحقق من هوية المريض** (معرفين: الاسم + تاريخ الميلاد)
- قيّم الحالة العقلية قبل السؤال عن الألم
- ضع المريض في وضع مريح أثناء التقييم
- تأكد من وصول جرس الطوارئ بعد التقييم
- تجنّب إحداث ألم إضافي أثناء الفحص
- ادعم المناطق المؤلمة أثناء حركة المريض
- راقب الآثار الجانبية للمسكنات (كبت تنفسي، تخدير)
- تحقق من الحساسية قبل إعطاء الدواء
- اتبع "حقوق إعطاء الدواء"
- راقب علامات تفاعلات الأدوية

Nurse Safety / سلامة الممرض

- Use **PPE** for suspected infectious patients
- Practice **safe body mechanics** when moving patients
- Ensure adequate assistance for repositioning
- Report needle-stick injuries immediately
- Be aware of workplace violence risks with agitated patients

- استخدم **معدات الوقاية الشخصية** للمرضى المعديين
- مارس **ميكانيكا الجسم الآمنة** عند تحريك المرضى
- تأكد من وجود مساعدة كافية لإعادة الوضع
- أبلغ عن إصابات وخز الإبر فوراً
- كن حذراً من مخاطر العنف مع المرضى الهائجين

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Top 10 Common Errors in Pain Assessment / أهم 10 أخطاء

#	Mistake (EN)	الخطأ (AR)
1	Assuming the patient's report is exaggerated	افتراض أن تقرير المريض مبالغ فيه
2	Using different scales at each assessment	استخدام مقاييس مختلفة في كل تقييم
3	Skipping reassessment after intervention	تخطي إعادة التقييم بعد التدخل
4	Estimating pain visually without scale	تقدير الألم بصرياً بدون مقياس
5	Not asking about non-pharmacological remedies used at home	عدم السؤال عن العلاجات غير الدوائية في المنزل
6	Ignoring cultural factors in pain expression	تجاهل العوامل الثقافية في التعبير عن الألم
7	Using wrong scale for patient age (adult scale for child)	استخدام مقياس خاطئ لعمر المريض
8	Documenting only the number, not qualitative descriptors	توثيق الرقم فقط دون الوصف النوعي
9	Delaying pain management while waiting for diagnosis	تأخير إدارة الألم انتظاراً للتشخيص
10	Not believing non-verbal patients (dementia, ICU)	عدم تصديق المرضى غير اللفظيين (خرف، ICU)

The #1 Mistake / الخطأ الأول

EN: Doubting the patient's self-report is the most dangerous mistake. Evidence suggests that healthcare providers' observational pain report cannot be assumed to be an accurate indicator of the patient's pain (Powell et al.). **Trust the patient!**

AR: الشك في تقرير المريض الذاتي هو أخطر خطأ. الأدلة تشير أن تقرير الممرض الملاحظ لا يمكن افتراضه دقيقاً لألم المريض. **ثق في المريض!**

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

28 — Red Flags in Pain Assessment العلامات الحمراء

Warning Signs Requiring Immediate Action / علامات تتطلب تدخلاً فورياً

RED FLAGS in Pain Assessment (URGENT):

1. **Sudden severe pain (10/10)** in a previously stable patient — possible acute event (MI, dissection, perforation)
2. **Pain unrelieved by usual doses** of prescribed analgesics — possible undertreatment or new pathology
3. **Chest pain radiating to jaw/arm** with diaphoresis, nausea — suspect MI
4. **Sudden severe abdominal pain** with rigid abdomen — suspect perforation, peritonitis
5. **Severe headache** "worst of my life" — suspect subarachnoid hemorrhage
6. **Back pain with neurological signs** (numbness, weakness, incontinence) — cauda equina
7. **Pain with fever >39°C** — suspect infection/sepsis
8. **Pain with respiratory distress or altered mental status**
9. **Signs of opioid overdose:** RR <10, pinpoint pupils, decreased LOC
10. **Pain during pregnancy** with bleeding — obstetric emergency

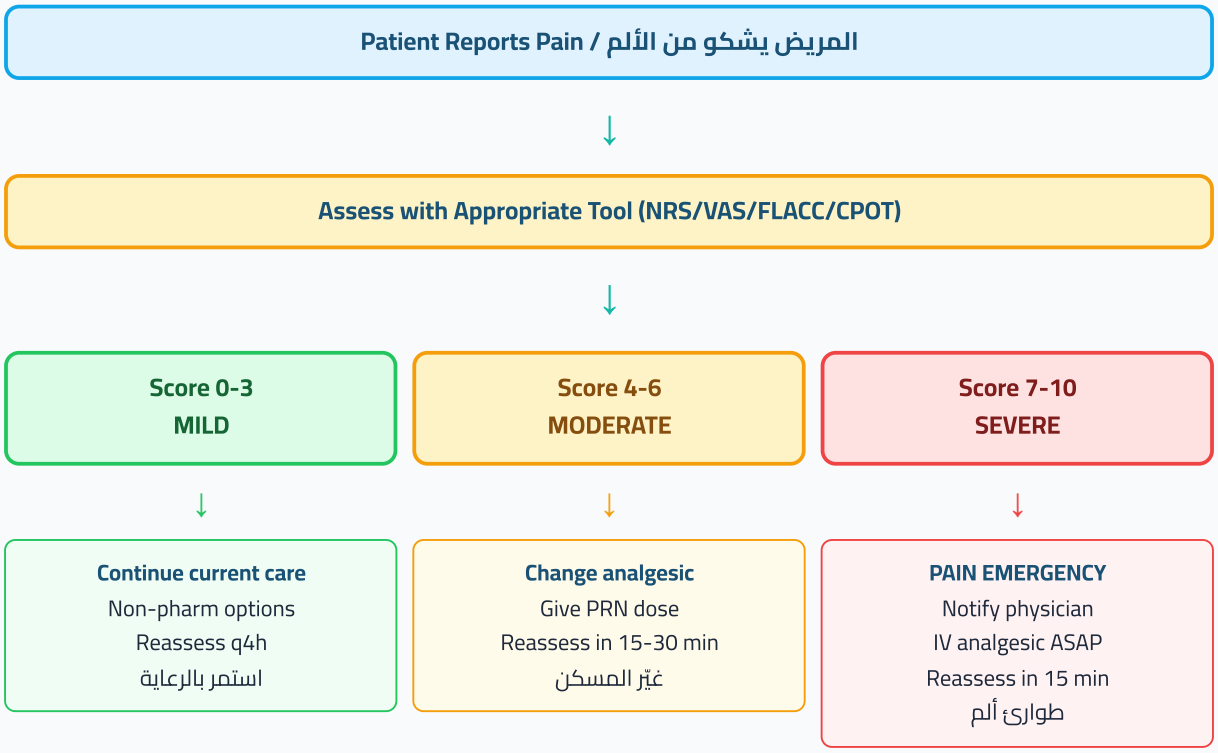
علامات حمراء (عاجلة):

- ألم شديد مفاجئ (10/10) في مريض مستقر — حدث حاد محتمل
- ألم لا يستجيب للجرعات المعتادة — احتمال قصور علاج أو مرض جديد
- ألم صدر ينتشر للفك/الذراع مع تعرق وغثيان — يشتبه MI
- ألم بطن شديد مع بطن صلبة — يشتبه انثقاب
- صداع شديد "أسوأ في حياتي" — يشتبه نزيف تحت العنكبوتية
- ألم ظهر مع علامات عصبية — ذيل الفرس
- ألم مع حمى >39 — يشتبه عدوى/تسمم
- ألم مع ضائقة تنفسية أو تغير الحالة العقلية
- علامات جرعة زائدة أفيون: RR<10، حدقة صغيرة، انخفاض الوعي
- ألم في الحمل مع نزيف — طوارئ ولادة

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Pain Assessment Decision Tree / شجرة قرار تقييم الألم

Pain Score Decision Pathway / مسار قرار درجة الألم



Decision Rule Interpretation / تفسير قاعدة القرار

EN: Pain intensity guides treatment: **0-3** generally requires no therapy change; **4-7** analgesic therapy has to be changed; **8-10** analgesic therapy has to be changed **immediately** — a pain emergency. (Powell et al., Pearls of Wisdom, IASP)

AR: شدة الألم توجه العلاج: **0-3** لا يحتاج تغيير علاج؛ **4-7** يجب تغيير المسكن؛ **8-10** يجب تغيير المسكن **فوراً** — حالة طوارئ ألم.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

30 — Abnormal Findings | النتائج غير الطبيعية

Abnormal Pain Findings by Score / النتائج غير الطبيعية حسب الدرجة

Score / الدرجة	Category / التصنيف	Findings / النتائج	Action / الإجراء
0	Normal / طبيعي	No pain, relaxed	Continue monitoring
1-3	Mild / خفيف	Bearable, minimal impact	Non-pharm; reassess
4-6	Moderate / متوسط	Interferes with activity, sleep	Analgesic + non-pharm
7-10	Severe / شديد	Incapacitating, disrupts function	**Urgent intervention**

Concerning Behavioral Findings / نتائج سلوكية مقلقة

- Persistent facial grimacing
- Guarding painful area
- Rigid body posture
- Refusing to move
- Withdrawal from social interaction
- Sleep disturbance related to pain
- Crying without stimulus

نتائج سلوكية مقلقة

- تكشيرة وجه مستمرة
- حماية المنطقة المؤلمة
- وضعية جسم متيبسة
- رفض الحركة
- انسحاب من التفاعل الاجتماعي
- اضطراب نوم متعلق بالألم
- بكاء بدون منبه

Abnormal Physiological Findings / نتائج فسيولوجية غير طبيعية

EN — Sympathetic Activation:

- HR >100 bpm (tachycardia)
- BP >140 mmHg systolic (hypertension)
- RR >20 breaths/min (tachypnea)
- Pallor and diaphoresis
- Pupil dilation
- Nausea & vomiting

AR — تنشيط الجهاز الودي:

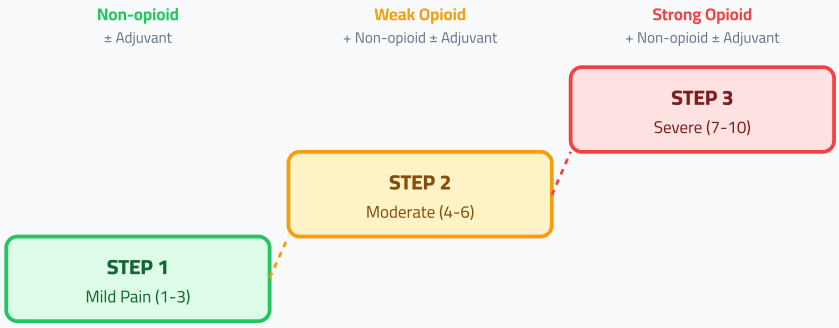
- نبض >100 (تسرع)
- ضغط >140 انقباضي
- تنفس >20/دقيقة
- شحوب وتعرق
- اتساع الحدقة
- غثيان وقيء

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

31 — Drug Notes & WHO Analgesic Ladder ملاحظات الأدوية وسلم WHO

WHO Analgesic Ladder (1986, updated 2019)

WHO 3-Step Analgesic Ladder / سلم WHO ثلاثي الخطوات



Step	Drug Class	Examples	Typical Dose
1	Non-opioid	Paracetamol (Dolo), Ibuprofen, Aspirin	PCM 650mg-1g q6h; Ibuprofen 400mg q8h
2	Weak Opioid	Codeine, Tramadol	Tramadol 50-100mg q6h (max 400mg/day)
3	Strong Opioid	Morphine, Fentanyl, Oxycodone	Morphine 5-10mg PO/SC q4h (titrate)
Adjuvants	Neuropathic/Anxiety	Gabapentin, Pregabalin, Amitriptyline	Gabapentin 300mg TID (titrate up)

Source: World Health Organization (WHO) Analgesic Ladder, 1986 updated 2019.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Opioid Adverse Effects

- **Respiratory depression** (RR <10)
- **Sedation** & confusion
- **Constipation** (very common)
- Nausea & vomiting
- Pruritus (itching)
- Urinary retention
- Miosis (pinpoint pupils)
- Tolerance & dependence

آثار جانبية للأفيونات

- **كبت تنفسي** (RR <10)
- **تخدير** وارتباك
- **إمساك** (شائع جداً)
- غثيان وقيء
- حكة
- احتباس بولي
- تضيق حدقة (رأس دبوس)
- تحمل واعتماد

Opioid Overdose — Emergency Signs / علامات جرعة زائدة

EN — Triad of Opioid Overdose:

- **Respiratory depression** (RR <10)
- **Pinpoint pupils** (miosis)
- **Decreased LOC** (unresponsive)

ANTIDOTE: Naloxone (Narcan) 0.4-2mg IV/IM/SC, may repeat q2-3 min

AR — ثلاثية جرعة زائدة:

- **كبت تنفسي** (RR <10)
- **حدقة رأس دبوس**
- **انخفاض الوعي**

الترياق: نالوكسون 0.4-2mg، يمكن تكراره كل 2-3 دقيقة

Nursing Considerations / اعتبارات تمريضية

- Check RR & sedation before EACH opioid dose
- Hold if RR <10 or excessive sedation
- Give stool softener with opioids
- Assess allergies (esp. morphine, codeine)
- Never crush extended-release tablets
- Educate patient about safe use

- افحص RR والتخدير قبل كل جرعة أفيون
- احتفظ إذا كان RR<10 أو تخدير مفرط
- أعطِ ملين براز مع الأفيونات
- قيّم الحساسية (خاصة المورفين والكودين)
- لا تسحق أبداً أقراص ممتدة المفعول
- ثقّف المريض عن الاستخدام الآمن

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

32 — Pediatric Pain Assessment & QUESTT

تقييم ألم الأطفال ونهج QUESTT

QUESTT Approach (Baker & Wong, 1987)

Does pain assessment differ with children? YES! Despite the previously held misconception that children do not experience pain due to underdeveloped neurological systems, **children DO feel pain**. The expression and detection can be more challenging than in adults.

The **QUESTT approach** was developed specifically for pediatric pain assessment:

Source: Baker & Wong (1987); Powell et al. (IASP).

Letter	Full Term (EN)	بالعربي
Q	**Question** the child if verbal, and the parent/guardian for both verbal and non-verbal child	**اسأل** الطفل إذا كان يتكلم، والوالد/الوصي للطفل اللفظي وغير اللفظي
U	**Use** pain rating scales if appropriate	**استخدم** مقاييس تقييم الألم إذا كان مناسباً
E	**Evaluate** behavior and physiological changes	**قيّم** التغيرات السلوكية والفسيولوجية
S	**Secure** the parent's involvement	**اضمن** مشاركة الوالدين
T	**Take** the cause of pain into account	**خذ** سبب الألم بعين الاعتبار
T	**Take** action and evaluate results	**اتخذ** إجراءً وقيّم النتائج

★ Key Principle / المبدأ الأساسي

EN: An effective pain assessment process is **as important for children as it is for adults**. Behavior alone is not necessarily a reliable indicator; use pain rating scale WITH investigation of physiological indicators (BP, HR, RR).

AR: عملية تقييم الألم الفعالة **مهمة للأطفال كأهميتها للبالغين**. السلوك وحده ليس مؤشراً موثوقاً؛ استخدم مقياس الألم مع فحص المؤشرات الفسيولوجية.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

33 — Children's Pain Tools: FLACC Scale أدوات ألم الأطفال: مقياس FLACC

FLACC Behavioral Pain Scale (Merkel et al., 1997)

The FLACC Behavioral Pain Scale is for patients who are verbally unable to report their pain. Each of the scale's five categories — **F**ace, **L**egs, **A**ctivity, **C**ry, **C**onsolability — is scored from 0-2, resulting in a total score of 0-10.

Source: Merkel et al. (1997); Powell et al. (IASP).

Category	0	1	2
Face	No expression, smile	Occasional grimace, withdrawn	Frequent/constant frown, clenched jaw
Legs	Normal position, relaxed	Uneasy, restless, tense	Kicking, or legs drawn up
Activity	Lying quietly, moves easily	Squirming, tense	Arched, rigid, or jerking
Cry	No cry	Moans, whimpers, occasional complaint	Crying steadily, screams, sobs
Consolability	Content, relaxed	Reassured by touch, hug, distraction	Difficult to console/comfort

Score Interpretation & Usage / تفسير الدرجة والاستخدام

Score Ranges:

- **0:** Relaxed and comfortable
- **1-3:** Mild discomfort
- **4-6:** Moderate pain
- **7-10:** Severe discomfort/pain

Awake patient: Observe for 2-5 min with legs/body uncovered.
Asleep patient: Observe for at least 5 min.

نطاقات الدرجات:

- **0:** مسترخي ومرتاح
- **1-3:** عدم ارتياح خفيف
- **4-6:** ألم متوسط
- **7-10:** ألم شديد

مريض مستيقظ: راقب 2-5 دقيقة مع كشف الساقين.
مريض نائم: راقب على الأقل 5 دقائق.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Additional Pediatric Pain Tools / أدوات ألم أطفال إضافية

Touch Visual Pain (TVP) Scale — for Children Unable/Unwilling to Report:

The 10-point TVP Scale uses **touch and observation** to assess pain AND anxiety/discomfort. Based on signs of pain that can be assessed by looking or touching:

- Asymmetrical head
- Verbalizations of pain
- Facial tension
- Clenched hands
- Crossed legs
- Shallow breathing
- Increased or irregular heartbeat

Process: Assign 1 (present) or 0 (not present) across 10 items for baseline. Give medication if needed. Reassess after 20-30 minutes. If no positive change → consider different approach.

Source: Powell et al. (IASP) — TVP is being used in low-resource settings; requires more validation.

مقياس Touch Visual Pain (TVP):

مقياس من 10 نقاط يستخدم **اللمس والملاحظة** لتقييم الألم والقلق. علامات تُقيّم بالنظر أو اللمس:

- رأس غير متماثل
- لفظ الألم
- توتر الوجه
- قبض اليدين
- تشابك الساقين
- تنفس سطحي
- نبض قلب متزايد أو غير منتظم

الطريقة: امنح 1 (موجود) أو 0 (غير موجود) لـ 10 عناصر. أعطِ الدواء إذا لزم. أعد التقييم بعد 20-30 دقيقة.

Pain Thermometer (For Children 7+ years)

EN: An **adaptation of the VDS**, this tool aligns a thermometer against words describing pain intensity levels. Developed for patients with cognitive deficits or communication difficulty

AR: تكييف لمقياس VDS، يحاذي ميزان حرارة مع كلمات تصف مستويات شدة الألم. طُوّر لمرضى العجز الإدراكي أو صعوبة التواصل. نسخة Iowa Pain Thermometer قابلة للاستخدام مع

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

34 — Age-Specific Challenges (Part 1) تحديات الفئات العمرية (الجزء 1)

Neonates & Infants & Toddlers / حديثو الولادة والرضع والأطفال الصغار

Neonates (0–1 month) Behavioral only

Challenge: Behavioral observation is the ONLY way to assess. Involve family/guardian who can advise on "normal" vs "abnormal" behavior patterns (unusually tense or relaxed).

Note: Behavior is NOT necessarily an accurate indicator. Absence of crying/movement does not always equate with absence of pain.

Ethical: Follow national ethical guidelines for parent/guardian presence and consent.

Infants (1 month – 1 year) Body signals

Signs:

- Body rigidity or thrashing
- Facial expression: brows lowered/drawn together, eyes tightly closed, mouth open and squarish
- Cry intensely or loudly, inconsolable
- Draw knees to chest
- Hypersensitivity or irritability
- Poor oral intake, unable to sleep

Toddlers (1–2 years) Verbal aggression

Signs:

- Verbally aggressive, cry intensely
- Regressive behavior, withdrawal
- Physical resistance, guard painful area
- Unable to sleep

Assessment: May be unable to communicate verbally, but **behavior expresses emotional and physical state**. Use play, drawings for non-verbal expression. Some children this age can use simple language.

Source: Powell et al. (IASP) — What are the challenges for pain assessment with the young?

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Preschoolers (3–5 years) Pain as punishment

Signs:

- Verbalize pain intensity
- See pain as **punishment**
- Thrash arms and legs, push stimuli away
- Uncooperative, need physical restraint
- Cling to parent, request emotional support (hugs, kisses)

Approach: Child needs to **trust the healthcare provider**. Overcome reservations concerning strangers. Take more time, use open-ended questions, use appropriate body language.

School-aged (6–12 years) Fear of consequences

Signs:

- Verbalize pain, use objective measure
- Influenced by cultural beliefs
- Pain-related nightmares
- Stalling behaviors ("Wait a minute")
- Muscular rigidity: clenched hands, white knuckles, gritted teeth, contracted limbs

Approach: More **reserved**, feels genuine fears. May deny pain fearing consequences (exam, injection). More articulate; can understand cause-and-effect. May ask spontaneous questions. **Involve them in own care**, give choices when possible.

Adolescents (13–18 years) Peer influence

Signs:

- Verbalize pain
- **Deny pain in presence of peers**
- Changes in sleep patterns or appetite
- Influenced by cultural beliefs
- Muscle tension, regressive behavior with family

Approach: May appear uncommunicative or disdainful. Express **genuine interest**, avoid confrontation. Focus on **adolescent as a person** (friends, school, hobbies), not just the problem. Avoid deliberate silence.

Source: Powell et al. (IASP), Chapter 10.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

35 — Elderly & Dementia Considerations — اعتبارات كبار السن والخرف

Does pain assessment differ with the aged? / هل يختلف تقييم الألم مع المسنين؟

Aged patients present additional challenges:

- May be **visually or cognitively challenged**
- May be **hearing impaired**
- Influenced by socially determined norms (not wanting to appear as a social burden)
- **Geriatric patients** with multiple morbidities and medications are especially problematic when they have **dementia**
- Such patients normally receive **inadequate analgesia** due to inability to communicate their need

Principal Rule for Geriatric Patients: ASK for pain (do not wait for spontaneous complaint).

Source: Powell et al. (IASP) — See Chapter 27 on Pain in Old Age and Dementia.

✦ ✦ ✦

المرضى المسنون يقدمون تحديات إضافية:

- قد يعانون من **ضعف بصري أو إدراكي**
- قد يعانون من **ضعف سمعي**
- يتأثرون بالمعايير الاجتماعية (لا يريدون الظهور كعبء اجتماعي)
- **المرضى المسنون** ذوو الأمراض المتعددة والأدوية المتعددة يشكلون مشكلة خاصة عند إصابتهم **بالخرف**
- هؤلاء المرضى عادةً يتلقون **مسكنات غير كافية** بسبب عدم القدرة على التواصل

القاعدة الرئيسية للمسنين: اسأل عن الألم (لا تنتظر الشكوى التلقائية).

★ Strategies for Elderly Assessment / استراتيجيات تقييم المسنين

For Cognitively Intact Elderly:

- **Increase text size** for visually impaired
- Include **relatives** in assessment when appropriate
- Avoid **"mental overload"** (multiple topics, insufficient explanation)
- Speak slowly and clearly
- Allow more time for responses
- Use hearing aids if available

للمسنين ذوي الإدراك السليم:

- **زد حجم النص** لضعاف البصر
- اشمل **الأقارب** في التقييم
- تجنّب **"الإرهاق الذهني"**
- تكلم ببطء ووضوح
- امنح وقتاً أكثر للاستجابة
- استخدم السماعات إذا توفرت

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Special Considerations for Pregnant Women / اعتبارات خاصة للحوامل

Pain Assessment During Pregnancy:

- Use **same pain scales** (NRS, VAS, VDS) as non-pregnant adults
- **Never dismiss pain** as "normal pregnancy discomfort" without assessment
- Distinguish physiological pregnancy pain from pathological pain
- Consider **trimester-specific** pain patterns
- Assess for **obstetric emergencies**: severe abdominal pain + bleeding = urgent
- Monitor for **preeclampsia**: severe headache, epigastric pain, visual changes

Common Pregnancy Pain Types: Round ligament pain (2nd trimester), back pain, pelvic pain, Braxton-Hicks contractions, labor contractions.

تقييم الألم أثناء الحمل:

- استخدم **نفس مقاييس الألم** (NRS, VAS, VDS) كما للبالغين غير الحوامل
- **لا تُهمل الألم أبداً** باعتباره "انزعاج حمل طبيعي" دون تقييم
- ميّز بين ألم الحمل الفسيولوجي والألم المرضي
- ضع في الاعتبار أنماط الألم **حسب فترة الحمل**
- قيّم **طوارئ الولادة**: ألم بطن شديد + نزيف = عاجل
- راقب **تسمم الحمل**: صداع شديد، ألم فوق المعدة، تغيرات بصرية

Obstetric Red Flags / علامات حمراء ولادية

EN — Requires Immediate Evaluation:

- Severe abdominal pain + bleeding → abruption/miscarriage
- Severe headache + visual changes → preeclampsia
- Epigastric pain → HELLP syndrome
- Regular contractions before 37 weeks → preterm labor
- Sudden severe pain + shock → ectopic rupture

AR — يتطلب تقييماً فورياً:

- ألم بطن شديد + نزيف ← انفصال/إجهاض
- صداع شديد + تغيرات بصرية ← تسمم حمل
- ألم فوق المعدة ← متلازمة HELLP
- انقباضات منتظمة قبل 37 أسبوعاً ← مخاض مبكر
- ألم شديد مفاجئ + صدمة ← تمزق حمل خارج الرحم

Medication Safety in Pregnancy / سلامة الأدوية في الحمل

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Pain Assessment in Critical Care / تقييم الألم في العناية المركزة

ICU Pain Assessment Challenges:

- Patients often **intubated/mechanically ventilated** — cannot self-report
- **Sedated** patients require behavioral scales
- Multiple invasive procedures cause continuous pain
- **PADIS Guidelines (2018)** recommend **CPOT as preferred tool** for non-verbal ICU patients
- Assess pain **continuously**, not just at intervals
- Consider pain BEFORE painful procedures (suctioning, positioning)

Source: Devlin et al. (2018) — PADIS Guidelines, Society of Critical Care Medicine.

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) — Gold Standard

Indicator	0	1	2
Facial expression	Relaxed, neutral	Tense	Grimacing
Body movements	Absence of movement	Protection	Restlessness/agitation
Muscle tension	Relaxed	Tense, rigid	Very tense/rigid
Ventilator compliance *(intubated)*	Tolerating	Coughing but tolerating	Fighting ventilator
Vocalization *(extubated)*	Talking normally	Sighing, moaning	Crying, sobbing

Total Score: 0-8 ▪ Score >2 indicates significant pain requiring intervention. Sensitivity 86%, Specificity 78% (Gélinas et al., 2006).

Behavioral Pain Scale (BPS) — Alternative for Sedated

Item	Description	Score
Facial expression	Relaxed to fully grimacing	1-4
Upper limbs	No movement to permanently retracted	1-4
Compliance with ventilation	Tolerating to unable to control	1-4

Total Score: 3-12 ▪ Score >5 indicates significant pain. Best for mechanically ventilated, deeply sedated patients

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Case 1: Pediatric Pain Assessment (Powell et al.)

1 Case Scenario / السيناريو

EN: You are working in a small, rural hospital when a **7-year-old girl** is brought in by her 13-year-old brother. She has AIDS and is **not on antiretroviral therapy**. She appears to be in some pain. **How do you assess that pain?**

AR: تعمل في مستشفى صغير في الريف عندما تُحضَر **طفلة عمرها 7 سنوات** بواسطة أخيها البالغ 13 سنة. لديها الإيدز وليست تحت العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. تبدو في بعض الألم. **كيف تُقيّم هذا الألم؟**

Answer / الإجابة

EN:

- The imperative is to **control the patient's pain as quickly as possible**
- Since she is 7 years old, the patient **should be able to verbalize her pain**
- Use the **body diagram** and the **Wong-Baker FACES Pain Rating Scale** in combination to achieve initial assessment of location, radiation, and severity
- Depending on severity, health care provider may be unable to complete a full assessment until pain has been managed
- The assessment process should, subject to her agreement, **involve both the girl and her older brother**
- Explore **brief family history** to determine if there is an adult carer or if she is being looked after exclusively by her older brother
- Ensure appropriate consent is obtained for possible therapeutic interventions
- If adult carer cannot be located quickly, may be necessary to **assess and treat pain while waiting**

AR: الضرورة هي **السيطرة على ألم المريضة بأسرع وقت**. بما أنها 7 سنوات، يجب أن تكون قادرة على التعبير عن ألمها. استخدم **مخطط الجسم** ومقياس **Wong-Baker FACES** معاً. اشمل الأخ الأكبر في التقييم، واحصل على الموافقة المناسبة قبل التدخلات العلاجية.

Source: Powell et al. (IASP), Chapter 10 — Case Studies.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

2 Case 2: Elderly Non-Verbal Patient

Scenario: You are in a home-based care team in a rural setting. You arrive to find an **elderly woman with end-stage cancer** curled up on her bed, crying, periodically drifting into semi-conscious state. **How do you assess her pain?**

Answer:

- Initial presenting behavior (crying, fetal position) suggests pain
- She's **unable to respond verbally** to pain chart/scale
- **Take history from carer**: what makes pain better/worse, duration, localized/referred
- Use **observational tool such as PAINAD**
- Additional questions: how long curled/crying, medications, worsening?
- In moments of consciousness, ask **closed questions** with squeeze/nod responses
- Supplement with **quick physical examination**
- Assessment based on: observation + physical exam + simple questions + comprehensive carer history

3 Case 3: Neonate with Suspected Pain

Scenario: You are in a regional hospital. A **week-old baby boy** is brought in by his mother experiencing **projectile vomiting** (typical of congenital hypertrophic pyloric stenosis, 1 in 500 babies). He will need surgery. Baby appears **tense and agitated**, you suspect pain. **How do you assess?**

Answer:

- Use the **FLACC scale**:
  - **F**ace: What is the expression?
  - **L**egs: Relaxed, restless/tense, or kicking?
  - **A**ctivity: Lying quietly, squirming, or rigid?
  - **C**ry: Crying and inconsolable?
  - **C**onsolability: Content or difficult to console?
- **Speak to his mother**: how long in condition, other symptoms, medical history, when pain started, aggravating/relieving factors
- Underlying cause may be **treatable (pyloric stenosis surgery)**
- **Critical to manage pain quickly** — also allows relaxation, making it easier to ascertain the cause

Source: Powell et al. (IASP), Chapter 10 — Case Studies.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

39 — Early Warning Scores (EWS) مقاييس التحذير المبكر

NEWS 2 — National Early Warning Score

NEWS 2 (National Early Warning Score) is used to detect clinical deterioration. Pain is one of the key subjective triggers that can accompany deterioration in vital signs. Nurses should combine pain assessment with EWS.

Parameter	3	2	1	0	1	2	3
Resp Rate	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
SpO2	≤91	92-93	94-95	≥96			
Temp (°C)	≤35		35.1-36	36.1-38	38.1-39	≥39.1	
Systolic BP	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Heart Rate	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Consciousness				Alert			VPU

Score 0-4
Low risk — Continue routine monitoring

Score 5-6
Medium risk — Urgent review, q1h vitals

Score ≥7
High risk — Emergency, notify MET/RRT

Pain + EWS Correlation / علاقة الألم بـ EWS

EN: Uncontrolled pain often elevates HR, RR, BP — increasing NEWS score. Always assess pain alongside vital signs to identify true clinical deterioration vs. pain-driven changes.

AR: الألم غير المُتحكم فيه غالباً يرفع النبض والتنفس والضغط — مما يزيد درجة NEWS. قيّم دائماً الألم بجانب العلامات الحيوية لتمييز التدهور السريري الحقيقي عن التغيرات الناتجة عن الألم.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Rapid Pain Assessment in Emergencies / تقييم سريع في الطوارئ

Rapid Pain Assessment Protocol (Emergency Department):

1. **Primary Survey First** — ABCDE before detailed pain assessment
2. **Quick Screen** — "On scale 0-10, how bad is your pain right now?"
3. **Location** — "Point to where it hurts"
4. **Onset** — "When did it start? What were you doing?"
5. **Character** — "Describe it in one word"
6. **Immediate action** if score ≥7 — IV access, MD notification
7. **Full PQRSTU** after stabilization

Emergency Pain Types

- **MI:** Crushing chest pain, radiates to jaw/arm
- **Aortic Dissection:** Tearing back pain
- **Perforation:** Sudden severe abdominal pain
- **SAH:** "Thunderclap" headache
- **Ectopic:** Unilateral pelvic pain + shock
- **Kidney stone:** Colicky flank pain
- **Testicular torsion:** Sudden scrotal pain

أنواع ألم طوارئ

- **احتشاء عضلة قلب:** ألم صدر ساحق ينتشر للفك/الذراع
- **تسلخ أورطي:** ألم ظهر تمزّقي
- **انثقاب:** ألم بطن حاد مفاجئ
- **نزيف تحت العنكبوتية:** صداع "صاعقة"
- **حمل خارج الرحم:** ألم حوض جانبي + صدمة
- **حصوة كلى:** ألم مغصي في الخاصرة
- **التواء الخصية:** ألم كيس صفن مفاجئ

Golden Rules / القواعد الذهبية

EN: (1) NEVER delay analgesia for diagnosis; (2) Use IV route for rapid onset (15 min peak); (3) Reassess in 15 min; (4) Document time, dose, response; (5) Watch for adverse effects.

AR: (1) لا تؤخر المسكن أبداً للتشخيص؛ (2) استخدم الطريق الوريدي لبدء سريع (15 دقيقة ذروة)؛ (3) أعد التقييم في 15 دقيقة؛ (4) وثّق الوقت والجرعة والاستجابة؛ (5) راقب الآثار الجانبية.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Pearls of Wisdom (Powell et al., IASP)

Essential Clinical Pearls:

- **Pain is subjective** — accept the patient as an expert on his/her own body
- **Every question provides essential information** about etiology and first steps to treatment
- **Pain intensity guides therapy:** 0-3 no change; 4-7 change analgesic; 8-10 emergency
- **Pain quality differentiates etiology:** "burning" → neuropathic; "dull, aching" → nociceptive; "unbearable" → affective valuation
- **Pain increase pattern helps identify etiology:** worst in early morning → inflammation; constant high level → chronic pain
- **Pain decrease pattern is diagnostic:** only rest helps → chronic pain; movement helps → possible osteoarthritis
- **Localization** is probably the most important question — differentiates radicular vs. nonradicular
- **Age matters** — pediatric pain requires QUESTT approach; elderly requires asking (not waiting)
- **Behavior alone is unreliable** — combine with physiological indicators (BP, HR, RR)
- **Non-pharmacological interventions** (Gate Control Theory) enhance pharmacological analgesia

Source: Powell, R.A. et al. Guide to Pain Management in Low-Resource Settings, Chapter 10 (IASP) — Pearls of Wisdom.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

10-Minute Rapid Revision / مراجعة سريعة 10 دقائق

Key Definitions (EN)

- **Pain (IASP 2020):** Unpleasant sensory + emotional experience with actual/potential tissue damage
- **Gate Control (Melzack & Wall 1965):** Non-painful stimuli close the gate
- **5th Vital Sign:** Pain (Joint Commission)
- **Gold Standard:** Patient's self-report (McCaffery, 1968)

تعريفات أساسية

- **الألم (IASP):** تجربة حسية + عاطفية مع تلف نسيج فعلي/محتمل
- **نظرية البوابة:** المنبهات غير المؤلمة تُغلق البوابة
- **العلامة الخامسة:** الألم
- **المعيار الذهبي:** تقرير المريض الذاتي

Pain Score Ranges — Quick Reference

Score	Level	Action
0	None	Continue monitoring
1-3	Mild	Non-pharm, reassess q4h
4-6	Moderate	Change analgesic, reassess 15-30 min
7-10	Severe	PAIN EMERGENCY, IV analgesic

Pain Tools Quick Match

- **Adults conscious:** NRS (0-10)
- **Children 3-8 yr:** Wong-Baker FACES
- **<3 yr / non-verbal:** FLACC (0-10)
- **ICU intubated:** CPOT (0-8) — Gold standard
- **Sedated:** BPS (3-12)
- **Dementia:** PAINAD (0-10)
- **Palliative care:** APCA POS (0-5)

Reassessment Timing

- **Oral analgesic:** Reassess in 30 min
- **IV analgesic:** Reassess in 15 min

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Print This Page for Clinical Reference / اطبع هذه للمرجع السريري

Component	Quick Reference
PQRSTU	P=Provocative/Palliative ▪ Q=Quality ▪ R=Region/Radiation ▪ S=Severity ▪ T=Time ▪ U=Understanding
OPQRST	O=Onset ▪ P=Provocation ▪ Q=Quality ▪ R=Radiation ▪ S=Severity ▪ T=Time
OLDCARTS	O=Onset ▪ L=Location ▪ D=Duration ▪ C=Character ▪ A=Aggravating ▪ R=Relieving ▪ T=Timing ▪ S=Severity
QUESTT (Peds)	Q=Question ▪ U=Use scales ▪ E=Evaluate behavior ▪ S=Secure parent ▪ T=Take cause ▪ T=Take action
FLACC	F=Face ▪ L=Legs ▪ A=Activity ▪ C=Cry ▪ C=Consolability (each 0-2, total 0-10)
Pain Scores	0=None ▪ 1-3=Mild ▪ 4-6=Moderate ▪ 7-10=Severe (Emergency at 8-10)
WHO Ladder	Step 1: Non-opioid → Step 2: Weak opioid → Step 3: Strong opioid (+/- Adjuvants at each step)
Reassessment	15 min post-IV ▪ 30 min post-oral ▪ q4h routine minimum
Opioid Overdose Triad	RR <10 + Pinpoint pupils + Decreased LOC → Naloxone 0.4-2mg IV
Physiological Signs	HR ↑, BP ↑, RR ↑, Pallor, Diaphoresis, Pupil dilation (sympathetic activation)
Behavioral Signs	Grimacing, Guarding, Moaning, Restlessness, Clenched fists, Withdrawal
Pain Types	Acute (<30d) ▪ Chronic (>3-6mo) ▪ Nociceptive (tissue) ▪ Neuropathic (nerve) ▪ Referred ▪ Phantom

Non-Pharmacological Interventions (Gate Control)

Close the gate with: Massage ▪ Heat/Cold ▪ TENS ▪ Distraction (music, TV) ▪ Guided imagery ▪ Deep breathing ▪ Repositioning ▪ Cutaneous stimulation

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

OSCE Station: Pain Assessment (20 Points)

- ✓ **1. Introduction:** Greet patient, introduce self, verify identity (2 identifiers)
- ✓ **2. Consent:** Explain procedure, obtain verbal consent
- ✓ **3. Hand hygiene:** Wash hands / use alcohol-based rub
- ✓ **4. Privacy:** Provide privacy screen if needed
- ✓ **5. Position:** Ensure patient comfort and good lighting
- ✓ **6. P — Provocation:** "What makes it better/worse?"
- ✓ **7. Q — Quality:** "How does it feel? Sharp/dull/burning?"
- ✓ **8. R — Region/Radiation:** "Show me where. Does it spread?"
- ✓ **9. S — Severity:** Use appropriate scale (NRS/VAS/FACES)
- ✓ **10. T — Time:** "Continuous or intermittent? How long?"
- ✓ **11. U — Understanding:** "How is it affecting your life?"
- ✓ **12. Home remedies:** Ask about non-pharm & pharm used
- ✓ **13. Behavioral observation:** Facial expression, guarding, body position
- ✓ **14. Physiological signs:** HR, BP, RR, diaphoresis, pallor
- ✓ **15. Documentation:** Complete pain assessment form
- ✓ **16. Plan interventions:** Pharmacological + non-pharmacological
- ✓ **17. Patient education:** Explain pain management plan
- ✓ **18. Reassessment plan:** State when to reassess (15/30 min)

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

46 — OSCE Examiner Tips نصائح الممتحن

What Examiners Look For / ما يبحث عنه الممتحنون

DO (High Marks)

- Start with clear introduction & consent
- Maintain **eye contact** with patient
- Use **open-ended questions** first
- Show empathy: "That sounds difficult"
- Use patient's OWN words when documenting
- Believe the patient's self-report
- Ask about **impact on function**
- Verbalize your findings out loud
- State reassessment plan clearly
- Complete hand hygiene visibly

DON'T (Lose Marks)

- Skip introduction or consent
- Use medical jargon patient won't understand
- Doubt or minimize patient's pain
- Estimate pain visually without scale
- Rush through PQRSTU
- Forget non-verbal observation
- Skip hand hygiene
- Focus only on numeric score
- Ignore cultural factors
- Fail to document reassessment

Communication Phrases That Earn Marks

- "I understand you're in pain. Let me help you."
- "On a scale from 0 to 10, where 0 is no pain and 10 is the worst pain you can imagine, what number would you give your pain right now?"
- "Can you describe the pain in your own words?"
- "Is there anything that makes it better or worse?"
- "How is this pain affecting your daily activities?"
- "I'll come back in 30 minutes to check on you."

Time Management

Typical OSCE Station: 7-10 minutes. Allocate: 1 min intro + consent, 4-5 min PQRSTU assessment, 1 min observation, 1-2 min documentation/plan, 1 min conclusion + reassessment plan.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Easy Ways to Remember / طرق سهلة للحفظ

PQRSTU — "People Question Real Suffering Truly Understand"

- **P**eople → **P**rovocative/Palliative
- **Q**uestion → **Q**uality
- **R**eal → **R**egion/Radiation
- **S**uffering → **S**everity
- **T**ruly → **T**ime
- **U**nderstand → **U**nderstanding/Impact

FLACC — "Face Legs Activity Cry Consolability"

Trick: Think of a baby — watch their **Face**, look at their **Legs**, note their **Activity**, listen to their **Cry**, try to **Console** them.

QUESTT (Pediatric) — "Question Use Evaluate Secure Take Take"

- **Q**uestion the child (if verbal) and parent (always)
- **U**se appropriate scales
- **E**valuate behavior + physiological changes
- **S**ecure parent's involvement
- **T**ake cause into account
- **T**ake action + evaluate results

Opioid Overdose — "PPP" (Triple P)

- **P**inpoint pupils (miosis)
- **P**oor breathing (RR <10)
- **P**oor consciousness (decreased LOC)

Treatment: Naloxone (Narcan) 0.4-2mg IV/IM

Pain Types — "ACPS-Referred-Phantom"

- **A**cute — sudden, <30 days
- **C**hronic — >3-6 months
- **P**hysiological — potential tissue damage

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

48 — Multiple Choice Questions (MCQs) أسئلة اختيار من متعدد

? Test Your Knowledge / اختبر معلوماتك

Q1. Who defined pain as an "unpleasant sensory and emotional experience"?

A) WHO B) IASP C) CDC D) NIH

Answer: B) IASP (2020)

Q2. The gold standard for pain assessment is:

A) Vital signs B) Nurse's observation C) Patient's self-report D) Family report

Answer: C) Patient's self-report (McCaffery, 1968)

Q3. Which scale is BEST for a non-verbal ICU patient on ventilator?

A) NRS B) VAS C) CPOT D) Wong-Baker

Answer: C) CPOT (Gold standard for ICU non-verbal, PADIS 2018)

Q4. A 2-year-old post-op child — which scale?

A) NRS B) FLACC C) VAS D) VDS

Answer: B) FLACC (best for <3 years non-verbal)

Q5. Reassess pain after IV analgesic in:

A) 5 minutes B) 15 minutes C) 30 minutes D) 60 minutes

Answer: B) 15 minutes (peak effect of IV analgesic)

Q6. Which is a "burning" pain descriptor typically associated with:

A) Nociceptive B) Neuropathic C) Visceral D) Somatic

Answer: B) Neuropathic pain (nerve damage)

Q7. WHO Analgesic Ladder Step 3 is:

A) Paracetamol B) Ibuprofen C) Tramadol D) Morphine

Answer: D) Morphine (Strong opioid for severe pain 7-10)

Q8. The triad of opioid overdose includes:

A) HTN, tachycardia, dilated pupils B) RR<10, pinpoint pupils, decreased LOC C) Fever, seizures, coma D) Hypoglycemia, sweating, tremor

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

49 — True / False Questions

صح أم خطأ

15 True / False Questions with Answers

1	Pain is the 5th vital sign.	TRUE
2	Nurse's observation is more accurate than patient's self-report.	FALSE
3	Children do not experience pain due to underdeveloped nervous systems.	FALSE
4	Phantom pain in amputees is a real pain phenomenon.	TRUE
5	Pain intensity of 8-10 is a medical emergency.	TRUE
6	Elderly patients with dementia often receive adequate analgesia.	FALSE
7	FLACC scale is used for children under 3 years or non-verbal.	TRUE
8	Gate Control Theory supports non-pharmacological interventions.	TRUE
9	IV analgesics peak effect occurs at 30 minutes.	FALSE
10	Localization is probably the most important question in pain assessment.	TRUE
11	Referred pain follows the course of a peripheral nerve.	FALSE
12	CPOT scale is the gold standard for ICU non-verbal patients.	TRUE
13	NSAIDs are safe throughout pregnancy.	FALSE
14	Naloxone reverses opioid overdose.	TRUE
15	Chronic pain persists longer than 3-6 months.	TRUE

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

50 — Fill in the Blanks أكمل الفراغ

Complete the Sentences / أكمل الجمل

1. The IASP redefined pain in the year _____.

   Answer: 2020

2. The 4 stages of pain pathway are transduction, transmission, _____, and modulation.

   Answer: perception

3. The Gate Control Theory was proposed by Melzack and Wall in _____.

   Answer: 1965

4. Pain score of _____ to _____ indicates moderate pain requiring analgesic change.

   Answer: 4 to 7 (or 4-6)

5. The FLACC scale evaluates Face, Legs, Activity, Cry, and _____.

   Answer: Consolability

6. The pediatric pain assessment approach is called _____.

   Answer: QUESTT

7. Reassessment after oral analgesic occurs at _____ minutes.

   Answer: 30

8. Reassessment after IV analgesic occurs at _____ minutes.

   Answer: 15

9. The antidote for opioid overdose is _____.

   Answer: Naloxone (Narcan)

10. The scale used for dementia patients unable to self-report is _____.

    Answer: PAINAD

11. The pain scale developed by Merkel et al. in 1997 for non-verbal children is _____.

    Answer: FLACC

12. Chest pain radiating to the jaw could indicate _____ (referred pain).

    Answer: Myocardial Infarction (MI/heart attack)

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

51 — Interactive Quiz (Scenarios) اختبار تفاعلي (سيناريوهات)

Scenario-Based Questions / أسئلة سيناريوهية

Scenario 1: 65-year-old post-op abdominal surgery, awake, rates pain 8/10 with sharp, stabbing quality. What is your priority action?

A) Continue monitoring B) Give heat pack C) Notify MD, prepare IV analgesic D) Wait for scheduled dose

Answer: C) Score 8/10 = Pain emergency. IV analgesic needed immediately.

Scenario 2: Intubated ICU patient shows grimacing, restlessness. CPOT score = 5. What does this indicate?

A) Normal B) Mild pain C) Significant pain requiring intervention D) Sedation needed

Answer: C) CPOT >2 = significant pain. Score 5 requires immediate analgesic.

Scenario 3: 4-year-old post-tonsillectomy. Which scale is most appropriate?

A) NRS 0-10 B) Wong-Baker FACES C) VAS D) CPOT

Answer: B) Wong-Baker FACES (ages 3-8, no literacy needed).

Scenario 4: Patient with dementia refuses to eat, shows facial grimacing. PAINAD score = 7. Best next step?

A) Force feeding B) Administer analgesic + reassess C) Ignore, patient can't speak D) Restrain patient

Answer: B) PAINAD 7 = severe pain. Treat and reassess in 15-30 min.

Scenario 5: Pregnant woman (28 weeks) with severe headache and visual changes. Concerning for?

A) Migraine B) Preeclampsia C) Sinusitis D) Normal pregnancy

Answer: B) Preeclampsia — obstetric emergency, notify OB immediately.

Scenario 6: Post-op patient given morphine 30 min ago. Now RR = 8, pinpoint pupils, difficult to arouse. Action?

A) Give more morphine B) Naloxone + call rapid response C) Reposition patient D) Wait and observe

Answer: B) Opioid overdose triad. Naloxone 0.4-2mg IV immediately.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Quick-Recall Flashcards / بطاقات استرجاع سريع

Q: Define pain per IASP (2020)?

A: Unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.

Q: 4 stages of pain pathway?

A: Transduction → Transmission → Perception → Modulation

Q: Best tool for ICU intubated patient?

A: CPOT (0-8). Score >2 = significant pain.

Q: FLACC categories?

A: Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (0-2 each, total 0-10)

Q: When to reassess after IV analgesic?

A: 15 minutes (peak effect)

Q: When to reassess after oral analgesic?

A: 30 minutes (peak effect)

Q: WHO Analgesic Ladder Step 1?

A: Non-opioid (paracetamol, NSAIDs) ± adjuvants

Q: WHO Analgesic Ladder Step 3?

A: Strong opioid (morphine, fentanyl) + non-opioid ± adjuvants

Q: Opioid overdose triad?

A: RR <10, pinpoint pupils, decreased LOC. Antidote: Naloxone.

Q: QUESTT stands for?

A: Question, Use scales, Evaluate, Secure parent, Take cause, Take action

Q: Gate Control Theory year & authors?

A: 1965 by Melzack & Wall

Q: Pain in dementia patient - which scale?

A: PAINAD (0-10) — observational tool

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Condensed Exam Summary / ملخص مكثف للامتحان

THE TOP 20 THINGS TO REMEMBER FOR EXAMS:

1. **IASP Definition:** Unpleasant sensory + emotional experience with tissue damage
2. **Pain = 5th Vital Sign** (Joint Commission)
3. **Gold Standard:** Patient's self-report
4. **Pain Pathway:** Transduction → Transmission → Perception → Modulation
5. **Gate Control Theory:** Melzack & Wall (1965)
6. **Adult scale:** NRS (0-10) most common
7. **Pediatric <3 yr:** FLACC
8. **Pediatric 3-8 yr:** Wong-Baker FACES
9. **ICU intubated:** CPOT (gold standard)
10. **Dementia:** PAINAD
11. **Score interpretation:** 0-3 mild, 4-6 moderate, 7-10 severe (8-10 emergency)
12. **Reassess:** 15 min post-IV, 30 min post-oral
13. **WHO Ladder:** Non-opioid → Weak opioid → Strong opioid
14. **PQRSTU:** Provocative-Quality-Region-Severity-Time-Understanding
15. **QUESTT:** Question-Use-Evaluate-Secure-Take-Take (pediatric)
16. **Neuropathic pain:** Burning, shooting, electrical
17. **Nociceptive pain:** Dull, aching
18. **Opioid overdose:** RR<10 + pinpoint pupils + ↓LOC → Naloxone
19. **Referred pain:** Chest pain → jaw (MI); shoulder pain (diaphragm)
20. **Phantom pain:** Real pain in amputated limb

Most Tested Concepts in NCLEX/Prometric

- Patient's self-report is gold standard
- Reassessment timing (15/30 min)
- Selecting correct scale for age/condition
- WHO analgesic ladder steps
- Opioid safety and overdose management
- Non-pharmacological interventions (Gate Control)

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Pain Assessment in NCLEX / تقييم الألم في NCLEX

NCLEX-RN Pain Assessment Priorities

- **Always believe the patient** — NCLEX considers self-report the gold standard
- **Assess before intervene:** use pain scale first
- **Prioritize physiological needs** (Maslow) — pain affects safety and ABCs
- **Non-pharmacological FIRST** for mild pain (Gate Control support)
- **Combined approach:** pharmacological + non-pharmacological gives best results
- **Reassess AFTER intervention:** critical for NCLEX pass
- **Never delegate pain assessment** to UAP — requires nursing judgment
- **Cultural competency:** respect different pain expressions

Prometric Exam Focus (Egypt/Gulf)

- WHO Analgesic Ladder application
- Correct scale for patient population
- Documentation standards
- Pediatric pain (FLACC, Wong-Baker)
- Post-operative pain management
- Cultural/religious considerations

Common Trap Questions

- Question asks "PRIORITY" — safety first, then pain
- Trap: assuming vital signs = pain accuracy (FALSE)
- Trap: choosing wrong scale for age
- Trap: giving analgesic without reassessment plan
- Trap: not believing patient's self-report

Test-Taking Strategy

1. **Read the stem carefully** — identify age, setting, condition
2. **Look for keywords:** "priority", "first action", "most appropriate"
3. **Apply Maslow:** physiological before psychological
4. **Apply ABC:** Airway, Breathing, Circulation before pain
5. **Choose ASSESSMENT before INTERVENTION** unless emergency
6. **Choose PATIENT REPORT** over nurse's observation
7. **Choose SYSTEMATIC approach** (PQRSTU) over random questions

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

55 — Frequently Asked Questions (FAQ) الأسئلة الشائعة

Common Questions from Nurses / أسئلة شائعة من الممرضين

Q1: What if a patient doesn't want to rate their pain?

Respect their choice, use behavioral observation instead. Document "patient declined to rate" and describe observed signs (grimacing, guarding, VS changes).

Q2: How often should I reassess pain?

Minimum q4h in hospital. After IV analgesic: 15 min. After oral: 30 min. After any procedure. When patient complains.

Q3: What if the patient scores 10/10 but appears comfortable?

Believe the patient. Pain is subjective. Cultural, psychological factors affect expression. Never say "you don't look like you're in pain."

Q4: Can I estimate pain visually without a scale?

NO. Always use validated scales. Nurse's visual estimation is unreliable per research (Powell et al.).

Q5: Which scale for a patient who speaks a different language?

Wong-Baker FACES (no language needed) or use translated NRS. Body diagram helps with location.

Q6: When should I call the physician about pain?

Score 7-10, sudden severe onset, unresponsive to analgesic, new radiating pain, associated with red flags (chest pain, dyspnea, altered LOC).

Q7: What is the maximum daily paracetamol dose?

Adults: 4 grams/day (4000mg). Elderly/liver disease: 2-3 grams/day. Always check.

Q8: How do I assess pain in a comatose patient?

Use behavioral scales: CPOT (if in ICU), FLACC, or PAINAD. Watch for grimacing, guarding, HR/BP/RR changes, restlessness.

Q9: Can I give more analgesic if score is still high after reassessment?

Follow the physician's order. If pain persists >4 despite max dose, contact MD for new orders. Consider multimodal approach.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Top 10 Essential Takeaways / أهم 10 نقاط أساسية

Essential Takeaways (EN)

1. **Believe the patient** — their self-report is the gold standard
2. **Pain is the 5th vital sign** — assess systematically
3. **Use validated scales** for the appropriate population
4. **Reassess after every intervention** (15 or 30 min)
5. **Multimodal analgesia** works best
6. **Non-pharmacological interventions** support (Gate Control)
7. **Consider special populations:** children, elderly, ICU, pregnancy
8. **Document accurately** using patient's own words
9. **Recognize red flags** requiring urgent intervention
10. **Advocate for adequate pain management** — it's a patient right

أهم النقاط (AR)

1. **صدّق المريض** — تقريره الذاتي هو المعيار الذهبي
2. **الألم هو العلامة الخامسة** — قيّمه بشكل منهجي
3. **استخدم مقاييس معتمدة** للفئة المناسبة
4. **أعد التقييم بعد كل تدخل** (15 أو 30 دقيقة)
5. **المسكنات متعددة الوسائط** تعمل بشكل أفضل
6. **التدخلات غير الدوائية** تدعم (نظرية البوابة)
7. **ضع في الاعتبار الفئات الخاصة:** أطفال، مسنين، ICU، حوامل
8. **وثّق بدقة** باستخدام كلمات المريض نفسها
9. **تعرّف على العلامات الحمراء** التي تتطلب تدخلاً عاجلاً
10. **ادعم إدارة الألم المناسبة** — إنه حق للمريض

Final Message from the Author

EN: Pain assessment is **not just a task — it's an act of compassion**. Every time you take the time to properly assess a patient's pain, you're validating their experience and giving them the care they deserve. Never dismiss, never doubt. Just **listen, observe, document, and act**.

AR: تقييم الألم **ليس مجرد مهمة — إنه فعل رحمة**. في كل مرة تخصص فيها الوقت لتقييم ألم المريض بشكل صحيح، أنت تُصدّق تجربته وتُقدم له الرعاية التي يستحقها. لا تُهمل أبداً، لا تشك أبداً. فقط **استمع، لاحظ، وثّق، وتصرف**.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Complete Comparison of Pain Assessment Tools

Tool	Advantages	Disadvantages
VAS	Quick, simple, well validated, easily translated, sensitive to changes	Too abstract for some; problematic for cognitive/visual/physical disability
NRS	Quick, simple, verbal use possible, well validated, easy to teach, detects treatment effects	Decreased reliability at age extremes; unreliable for non-verbal/cognitively impaired
VDS	Quick, easily comprehended, well validated, intuitively preferred	Language dependent, cultural interpretation issues; problematic for young/old/illiterate
Wong-Baker FACES	Simple, quick, no reading required, unaffected by gender/ethnicity, provides 3 scales in one	Sometimes described as measuring mood not pain; crying faces not culturally universal
FLACC	Useful for non-verbal children; quick, easily reproducible	Not validated for special needs children, neonates, or ventilated children
TVP	Useful for children unable to report; quick, easily reproducible	Requires additional research for validation in different populations
Pain Thermometer	Simple, quick, intuitive for those uncomfortable with numbers	Problematic for cognitively/visually impaired patients
CPOT	Gold standard ICU; high sensitivity/specificity; validated for non-verbal patients	Requires trained observer; not usable in patients with complete paralysis
PAINAD	Useful for advanced dementia; quick, easily reproducible	Relies on proxy indicators; less specific than self-report
APCA POS	Comprehensive palliative care assessment; WHO-endorsed	Only addresses pain as single domain; requires staff training

Source: Powell et al. (IASP), Appendix 2 — McLafferty and Farley (2008).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

58 — Related Articles مقالات ذات صلة

Continue Learning at NurseHub Egypt / تابع التعلم

Recommended Related Articles on NurseHub Egypt:

1. Vital Signs Assessment Complete Guide
Learn how to assess BP, HR, RR, Temp, SpO2, and their relationship with pain.

2. Medication Administration & Safety
Rights of medication administration, IV/IM/PO routes, dose calculations.

3. Wound Care Assessment & Management
Wound staging, dressing selection, pain during dressing changes.

4. Post-Operative Nursing Care
PACU protocols, pain management, complications monitoring.

5. Pediatric Nursing Assessment
Growth & development, age-specific care, family-centered approach.

6. ICU Nursing Essentials
Ventilator care, sedation assessment, hemodynamic monitoring.

7. Palliative & End-of-Life Care
Symptom management, family support, cultural considerations.

8. Nursing Documentation Standards
Legal aspects, SBAR communication, EMR best practices.

Visit us at nursehub-egypt.vercel.app

New articles added weekly ▪ PDF downloads available ▪ Bilingual content ▪ NCLEX & Prometric preparation ▪ Free basic content, premium PDFs 50 EGP each

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Evidence-Based References / المراجع المعتمدة

Primary Sources / المصادر الأساسية:

1. Baker, C. M., & Wong, D. L. (1987). QUEST: A process of pain assessment in children. *Orthopedic Nursing, 6*(1), 11-21.
2. Bates, B. (1991). *A guide to physical examination and history taking* (5th ed.). J.B. Lippincott.
3. Devisri, R. *PPT Pain Assessment and Management*. Karpaga Vinayaga College of Nursing.
4. Devlin, J. W., et al. (2018). Clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU. *Critical Care Medicine, 46*(9), e825-e873.
5. Gélinas, C., Fillion, L., Puntillo, K. A., Viens, C., & Fortier, M. (2006). Validation of the Critical-Care Pain Observation Tool in adult patients. *American Journal of Critical Care, 15*(4), 420-427.
6. Herr, K., Coyne, P. J., McCaffery, M., Manworren, R., & Merkel, S. (2011). Pain assessment in the patient unable to self-report. *Pain Management Nursing, 12*(4), 230-250.
7. International Association for the Study of Pain (IASP). (2020). IASP terminology. Retrieved from https://www.iasp-pain.org/terminology
8. Joint Commission. (2017). *Pain assessment and management standards for hospitals*. Joint Commission Resources.
9. McCaffery, M. (1968). *Nursing practice theories related to cognition, bodily pain, and man-environment interactions*. UCLA Students' Store.
10. Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. *Science, 150*(3699), 971-979.
11. Merkel, S. I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., & Malviya, S. (1997). The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. *Pediatric Nursing, 23*(3), 293-297.
12. Powell, R. A., Downing, J., Ddungu, H., & Mwangi-Powell, F. N. Pain history and pain assessment. In *Guide to Pain Management in Low-Resource Settings* (Chapter 10). International Association for the Study of Pain (IASP).
13. Raja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., et al. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain. *Pain, 161*(9), 1976-1982.
14. Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO). (2013). *Assessment and management of pain* (3rd ed.). Toronto: RNAO.
15. SimpleNursing. *Stress, Pain & Homeostasis*. Pathophysiology Course, p. 74.
16. Wilson, D., & Hockberry, M. J. (2008). *Wong's clinical manual of pediatric nursing* (7th ed.). Mosby Elsevier.
17. World Health Organization (WHO). (2019). *WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents*. Geneva: WHO.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025



Thank You!

شكراً لاختيارك NurseHub Egypt

This comprehensive guide was created by nurses, for nurses.

هذا الدليل الشامل صُنع بواسطة الممرضين، لأجل الممرضين.

RN, Ali Ashour, BSN

أخصائي عناية مركزة (ICU) — خبرة 6 سنوات

BLS Certified

Website	WhatsApp	Vodafone Cash
nursehub-egypt.vercel.app	01095652098	01013489017

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

Pain Assessment Comprehensive Clinical Guide — Version 1.0